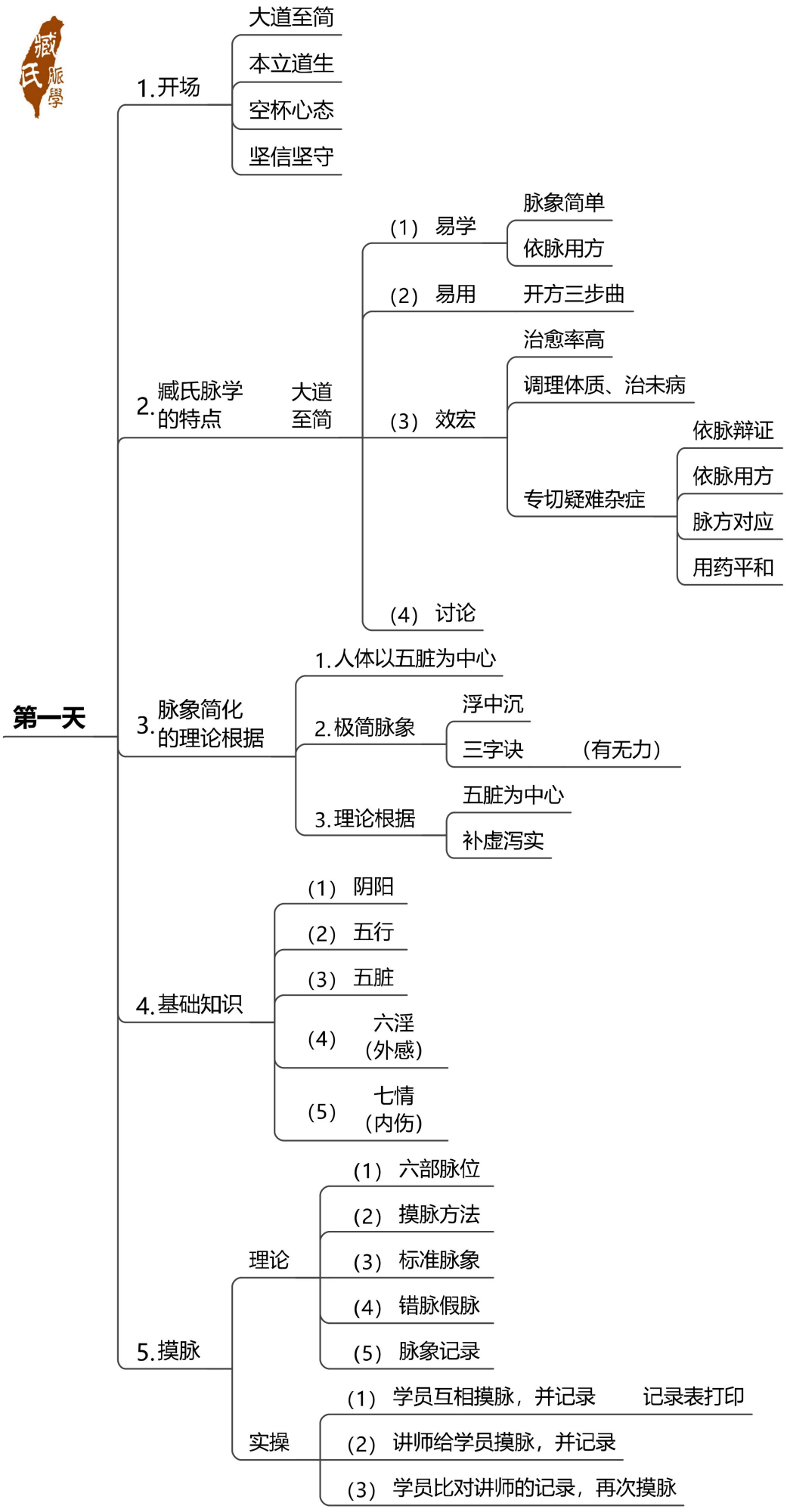
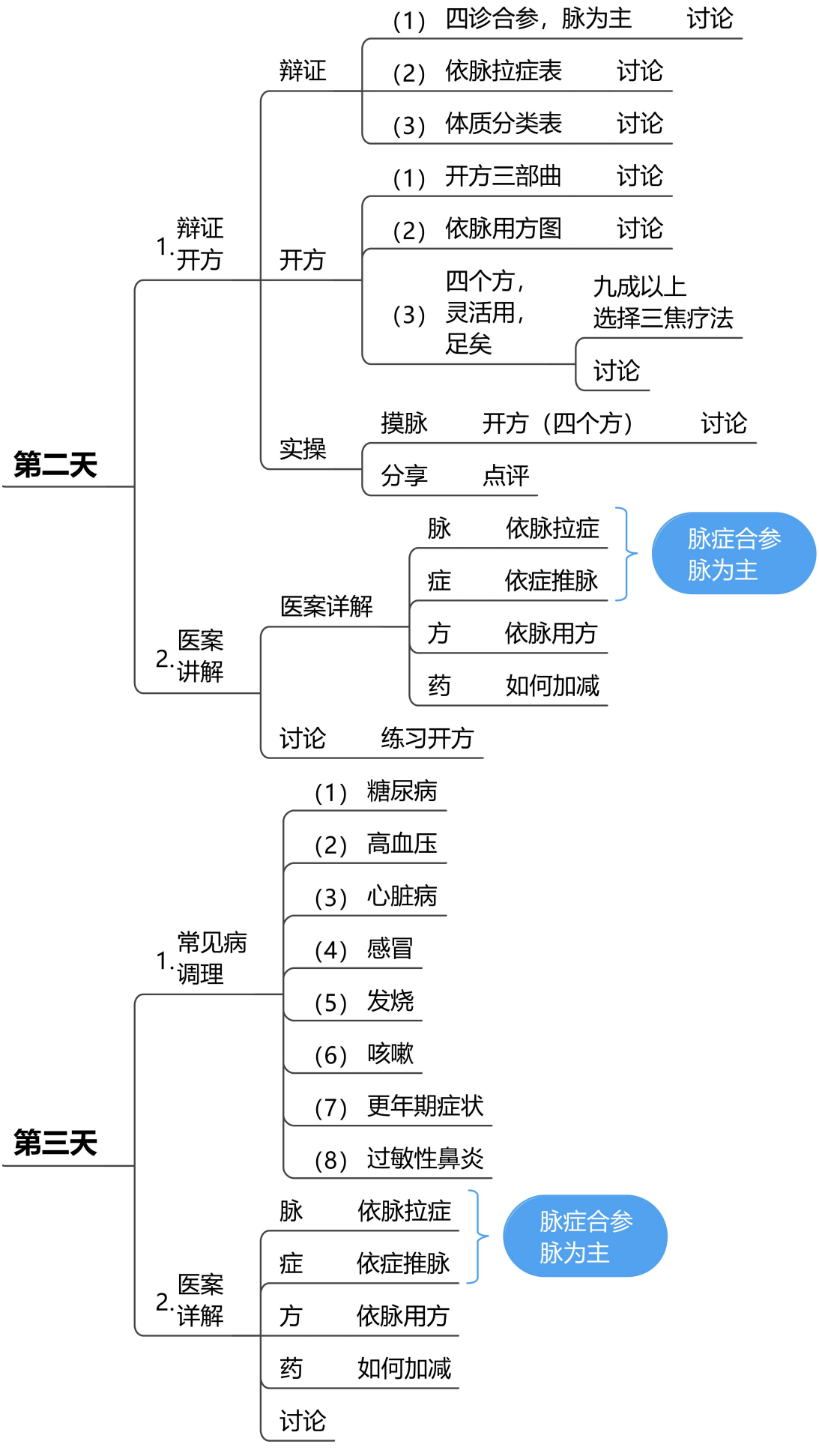
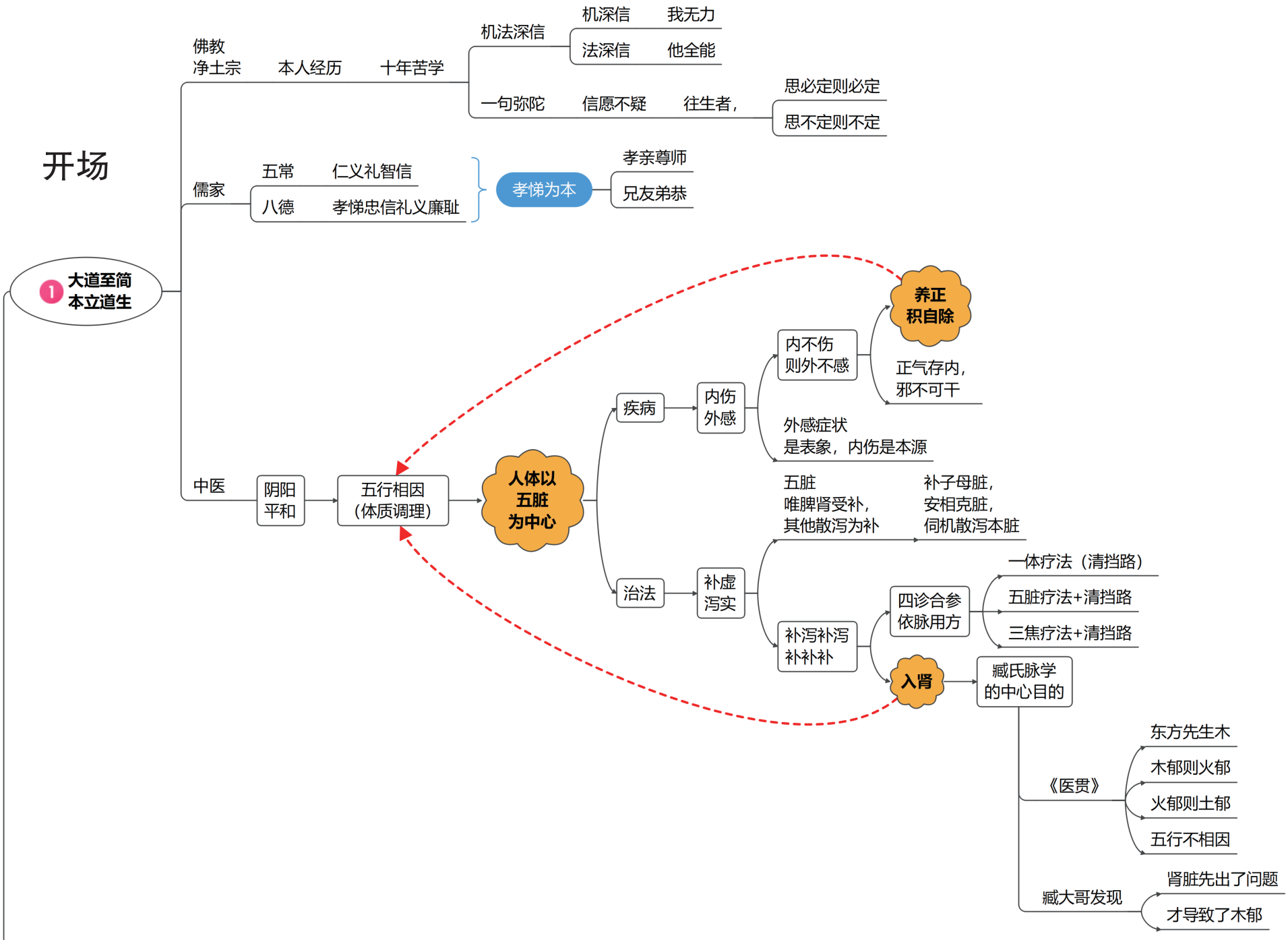
天津线下班 · 讲义

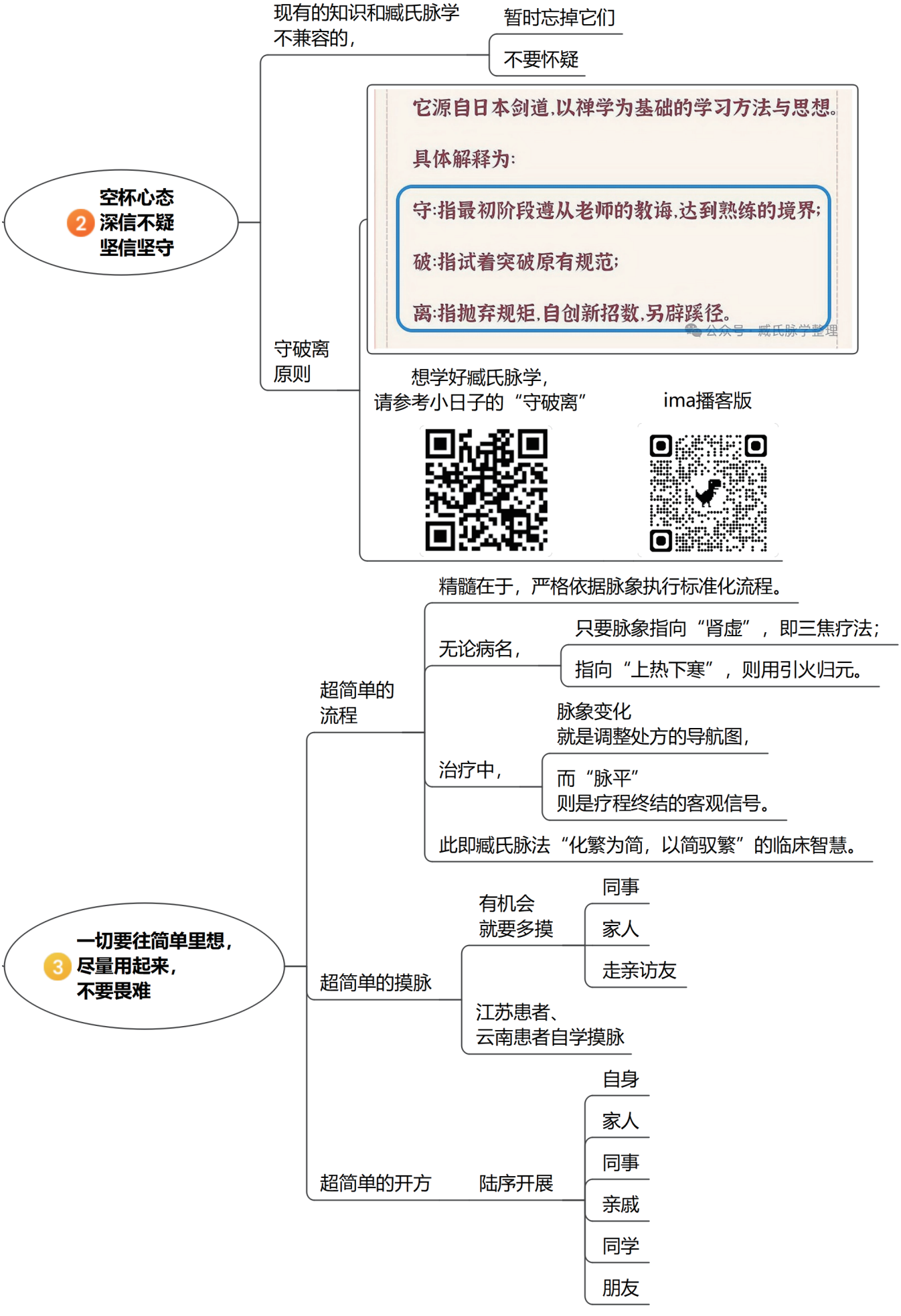
（2026-10）


第一天
1.开场
大道至简
本立道生
空杯心态
坚信坚守
2.臧氏脉学的特点
大道至简
(1) 易学
脉象简单
依脉用方
(2) 易用
开方三步曲
(3) 效宏
治愈率高
调理体质、治未病
专切疑难杂症
依脉辩证
依脉用方
脉方对应
用药平和
(4) 讨论
3.脉象简化的理论根据
1.人体以五脏为中心
2.极简脉象
浮中沉
三字诀
(有无力)
3.理论根据
五脏为中心
补虚泻实
4.基础知识
(1) 阴阳
(2) 五行
(3) 五脏
(4) 六淫 (外感)
(5) 七情 (内伤)
5.摸脉
理论
(1) 六部脉位
(2) 摸脉方法
(3) 标准脉象
(4) 错脉假脉
(5) 脉象记录
实操
(1) 学员互相摸脉，并记录
记录表打印
(2) 讲师给学员摸脉，并记录
(3) 学员比对讲师的记录，再次摸脉


第二天
1. 辩证开方
辩证
(1) 四诊合参，脉为主 讨论
(2) 依脉拉症表 讨论
(3) 体质分类表 讨论
开方
(1) 开方三部曲 讨论
(2) 依脉用方图 讨论
(3) 四个方，灵活用，足矣
九成以上选择三焦疗法
讨论
实操
摸脉 开方（四个方） 讨论
分享 点评
2. 医案讲解
医案详解
脉 依脉拉症
症 依症推脉
脉症合参脉为主
方 依脉用方
药 如何加减
讨论 练习开方
第三天
1. 常见病调理
(1) 糖尿病
(2) 高血压
(3) 心脏病
(4) 感冒
(5) 发烧
(6) 咳嗽
(7) 更年期症状
(8) 过敏性鼻炎
2. 医案详解
脉 依脉拉症
症 依症推脉
脉症合参脉为主
方 依脉用方
药 如何加减
讨论

开场


1 大道至简 本立道生
佛教
净土宗
本人经历
十年苦学
机法深信
机深信
我无力
法深信
他全能
一句弥陀
信愿不疑
往生者，
思必定则必定
思不定则不定
儒家
五常
仁义礼智信
八德
孝悌忠信礼义廉耻
孝悌为本
孝亲尊师
兄友弟恭
中医
阴阳平和
五行相因（体质调理）
人体以五脏为中心
疾病
内伤外感
内不伤则外不感
养正积自除
正气存内，邪不可干
外感症状是表象，内伤是本源
治法
补虚泻实
五脏唯脾肾受补，其他散泻为补
补子母脏，安相克脏，伺机散泻本脏
补泻补泻补补补
四诊合参依脉用方
一体疗法（清挡路）
五脏疗法+清挡路
三焦疗法+清挡路
入肾
臧氏脉学的中心目的
《医贯》
东方先生木
木郁则火郁
火郁则土郁
五行不相因
臧大哥发现
肾脏先出了问题
才导致了木郁


2 空杯心态 深信不疑 坚信坚守
现有的知识和臧氏脉学不兼容的，
暂时忘掉它们
不要怀疑
守破离原则
它源自日本剑道，以禅学为基础的学习方法与思想。
具体解释为：
守：指最初阶段遵从老师的教诲，达到熟练的境界；
破：指试着突破原有规范；
离：指抛弃规矩，自创新招数，另辟蹊径。
公众号：臧氏脉学整理
想学好臧氏脉学，
请参考小日子的“守破离”
ima播客版
3 一切要往简单里想，尽量用起来，不要畏难
超简单的流程
精髓在于，严格依据脉象执行标准化流程。
无论病名，
只要脉象指向“肾虚”，即三焦疗法；
指向“上热下寒”，则用引火归元。
治疗中，
脉象变化
就是调整处方的导航图，
而“脉平”
则是疗程终结的客观信号。
此即臧氏脉法“化繁为简，以简驭繁”的临床智慧。
超简单的摸脉
有机会
就要多摸
同事
家人
走亲访友
江苏患者、
云南患者自学摸脉
超简单的开方
陆序开展
自身
家人
同事
亲戚
同学
朋友

第一步：入门级

1. 只选一个方　脾胃
2. 再选一个方　下焦方
3. 再选一个方　上焦方
4. **四个方，灵活用，足矣！**

一、请背诵以下四方，余方可输入手机

（一）上焦方：二仁茯耆药

（二）中焦方：参术苓草陈耆

（三）下焦方：何苓膝，归杞菟故

（四）六味桂：地山山，苓泽丹

二、倘能将上方灵活运用，足矣

- 双寸浮大，右关泻。
  - 大哥：茯苓拉高
  - +天冬麦冬丹参
- 左寸无力，加中温。
  - 子母脏关系
- 左关浮大，土中泻。
  - 土中泻木（木瓜白芍）

中焦方

- 左关无力，滋肾阴。
  - 肝肾同源
肝肾同一治
滋肾以补肝
- 尺脉有力，知柏泻，
  - 知柏+六味桂
- 尺脉无力，直攻肾。

下焦方
六味桂

臧大哥

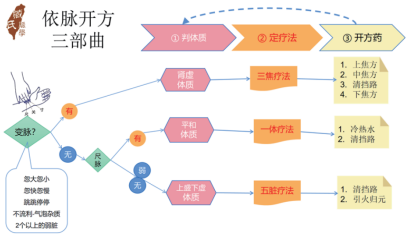
4个方，6句话，够你用的了——
其他都不要，你可以吃掉大概6成的病。

一般找你看的病人都很单纯，不会很复杂，
这几个方子就能治得下来了，所以不用担心。

你的目标设定在哪里?

第二步:初级(家庭保险) 慢慢调理

- 应用
  - (1) 调理慢性病
  - (2) 调理体质
  - (3) 治未病
- 理论
  - 三焦疗法 臧大哥
    - 我们的精华就在三焦疗法,
    - 你若习得三焦疗法,可以灵活运用,
    - 我跟你讲—— 你绝对成为绝世高手
    - 因为三焦疗法专切疑难杂症。
    - 三焦疗法主要的目的, 就是让五行相因
  - 臧氏脉学的秘密诀窍——补充肾脏能量
    - "补充肾脏能量,把它依存的关系搭上来"
    - 我这套东西就是这一句话和两帖肾药在耍!
  - 三焦疗法+简单清挡路
    - 挡路不清,肾药下行受影响,但是可以入肾
    - 九成以上的人,适合三焦疗法直接进入"开方药"即可



第三步:中级(家庭医生)

- 应急处理
  - 快速应对
    - 感冒
    - 发烧
    - 咳嗽
  - 理论水平
    - 三种疗法
    - 病因病机
    - 依脉用方
- 好多病可以缓解
- 脉方很简单

对应的方(15种)

脉象编号	方剂名称	方剂编号
1	知柏地黄	①
2		
3	上焦方	②
4	滋肾补肝(下焦方)	③
5	补脾	
6	加温(理中/五异)	④/⑤
7	两段治(滋阴/加温)	④⑤⑪⑫⑬
8		
9	滋肾补肝(下焦方)	③
10	天王芪	⑥
11	散泻和	⑦⑧⑨
12	参苏	⑩
13	滋阴(六神/增液/易简)	⑪⑫⑬
14		
15		
16	知柏地黄	①
11+10	肝心同治	⑭
11+12	肝肺同治	⑧
11+14	双关同治	⑮

需要处理的脉(16种)

脉位			需要处理的脉象编号 有	无	力
左	左寸 → 心	浮		3	10
		中			
		沉			
	左关 → 肝	浮		4	11
		中			
		沉			
右	右寸 → 肺	浮		5	12
		中			
		沉			
	右关 → 脾	浮		6	13
		中		7	14
		沉		8	15
双尺 → 肾		浮	1		16
		中	2		
		沉		9	

第四步:高级(小有名气) 得心应手

- 理论水平
  - 四诊合参
  - 病因病机
  - 预判转方
- 操作水平 熟练、准确开方

第五步:专家(当地名医)

- 臧氏脉学的特点
  - ① 依脉辩证 — 专切疑难杂症
    - 依脉辩证，无论其症，依脉用方，脉方对应，全是套方，不用症状方，避免漫无头绪地试药
    - 补养脾肾，调理体质，恢复身体自愈力，疑难杂症逐渐可消
  - ② 脉方对应 — 一脉对应一方
    - 治病即治脉
    - 见依脉拉方表
  - ③ 补泻并行 — 中医最高境界
    - 同一天或者隔日完成补养和泻邪
  - ④ 分步用药
    - 先清挡路，再入肾药
      - 脾胃虚弱的，药物很难吸收，则应先调理脾胃
      - 肝肺邪气盛，肾药不能下行，应提前调理肝肺
      - 心脏有问题，肾药不能下行，应提前调理心脉
      - 肾脉亢或不平衡，肾药不能下行，要打到衰和平衡
    - 如果以上的药放在一起同时服用 — 人体不能按照医生的想法来安排药的去处
  - ⑤ 分脏用药 — 精准调理、专攻高效
  - ⑥ 分时用药 — 服药时间不同，效果不同
    - 餐前后 — 脾胃药
    - 两餐间 — 肝肺药
    - 空腹时 — 入肾药
    - 睡觉前 — 补心药
  - ⑦ 用药平和
    - 丁香、八角茴香、刀豆、小茴香、小蓟、山药、山楂、马齿苋、乌梢蛇、乌梅、木瓜、火麻仁、代代花、玉竹、甘草、白芷、白果、白扁豆、白扁豆花、龙眼肉（桂圆）、决明子、百合、肉豆蔻、肉桂、余甘子、佛手、杏仁（甜、苦）、沙棘、牡蛎、芡实、花椒、赤小豆、阿胶、鸡内金、麦芽、昆布、枣（大枣、酸枣、黑枣）、罗汉果、郁李仁、金银花、青果、鱼腥草、姜（生姜、干姜）、枳椇子、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、茯苓、香橼、香薷、桃仁、桑叶、桑椹、桔红、桔梗、益智仁、荷叶、莱菔子、莲子、高良姜、淡竹叶、淡豆豉、菊花、菊苣、黄芥子、黄精、紫苏、紫苏籽、葛根、黑芝麻、黑胡椒、槐米、槐花、蒲公英、蜂蜜、椪子、酸枣仁、鲜白茅根、鲜芦根、蝮蛇、橘皮、薄荷、薏苡仁、薤白、覆盆子、藿香、当归、山柰、西红花、草果、姜黄、荜茇、党参、肉苁蓉（荒漠）、铁皮石斛、西洋参、黄芪、灵芝、山茱萸、天麻、杜仲叶、地黄、麦冬、天冬、化橘红
      - 臧氏用药七成是药食同源 — 药食同源物质总数106种 — 红色为本门所用，共45种。
  - ⑧ 可以现解 — 现场解除症状
    - 治脉即治病
    - 脉平症自消
  - ⑨ 调理体质 — 不只消除症状
    - 身体会越来越好
    - 所谓调理体质，就是补充脾、肾两脏不足，使五行相因。

正气存内，　　体质好，
邪不可干　　邪不能扰

上医治未病　　治未病
下医治已病　　就是调理体质

⑩ 可治未病

《素问·四气调神大论》：
圣人不治已病，治未病；
不治已乱，治未乱。
夫病已成而后药之，乱已成而后治之，
譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎。

高度智慧的人
对于疾病，
不着重于治疗，
而是着重于
预防疾病的发生，
在平时就做好防患的工作。

善治者，治皮毛；
其次肌肤，其次治筋脉；
其次治六腑；
其次治五脏。
治五脏者，半死半生也。

（壮实之人，可适用，即伤寒用方理念。
今时之人，几乎已完全不适用，
给五脏能量，将虚邪贼风，驱出体外，
或许是唯一选择。）

⑪ **专切疑难**

专切疑难杂症

用方
① 依脉辩证　疑难杂症，方便切入
② 脉方对应　精准调理，规范用方
③ 补泻并行　最高境界，无人能及

用药
④ 分步用药　先清挡路，再入肾药
⑤ 分脏用药　精准调理，专攻高效
⑥ 分时用药　时间不同，效果不同
⑦ 用药平和　七成所用，药食同源

效果
⑧ 可以现解　脉平为期，症状缓解
⑨ 调理体质　补养脾肾，五行相因
⑩ 可治未病　调理体质，百病不生
预防为主，最高追求

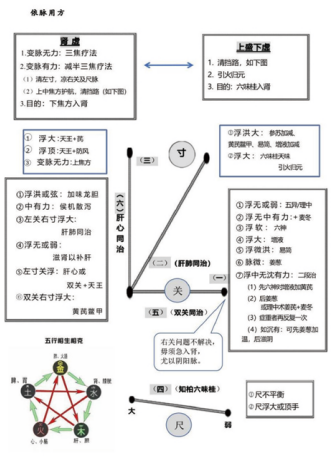
（1） 易学

臧氏脉学
为什么
容易学会？

1.辩证简单，一学就会　依脉辩证，舍症取脉（中医诊断学不需要）
2.辩证之后，即可开方　脉方对应，全是套方（中医方剂学不用学）
3.开方之后，不用加减　症状之药，不需添加（中药学可以不看）
4.大道至简，无需基础　全是套路，适合小白（中医四大经典不用学）

开方的秘诀
就在——
这张表里

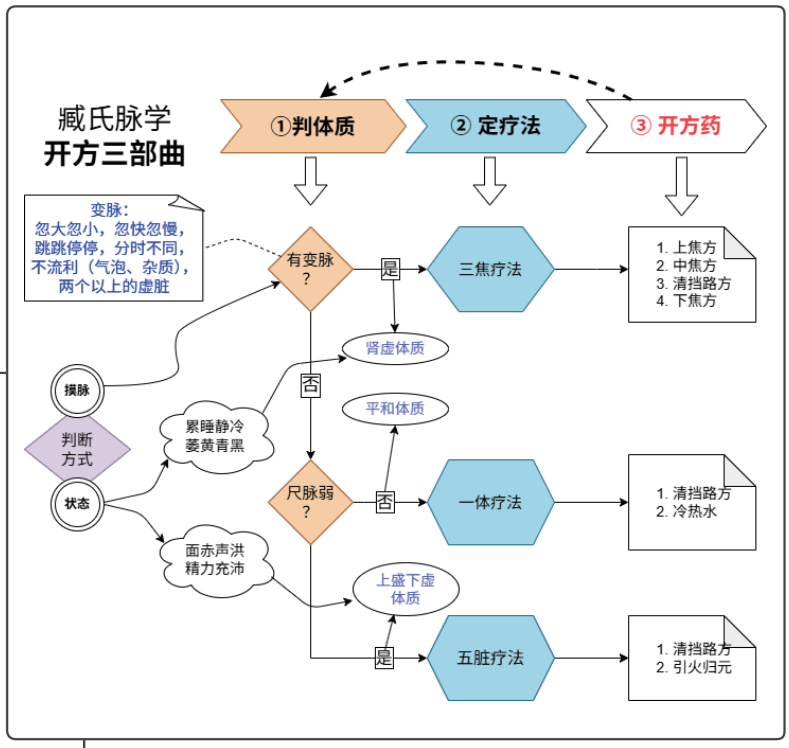
依脉用方表



大道至简

大道至简

(2) 易用



依脉辩证

依脉开方

脉方对应

依脉拉症

依脉拉个性

快速信任

(3) 效宏

治愈率高

调理体质

专切疑难杂症

依脉辩证

依脉用方

脉方对应

(4) 讨论

臧氏脉学的易学易用效宏，

你认可吗　　为什么？

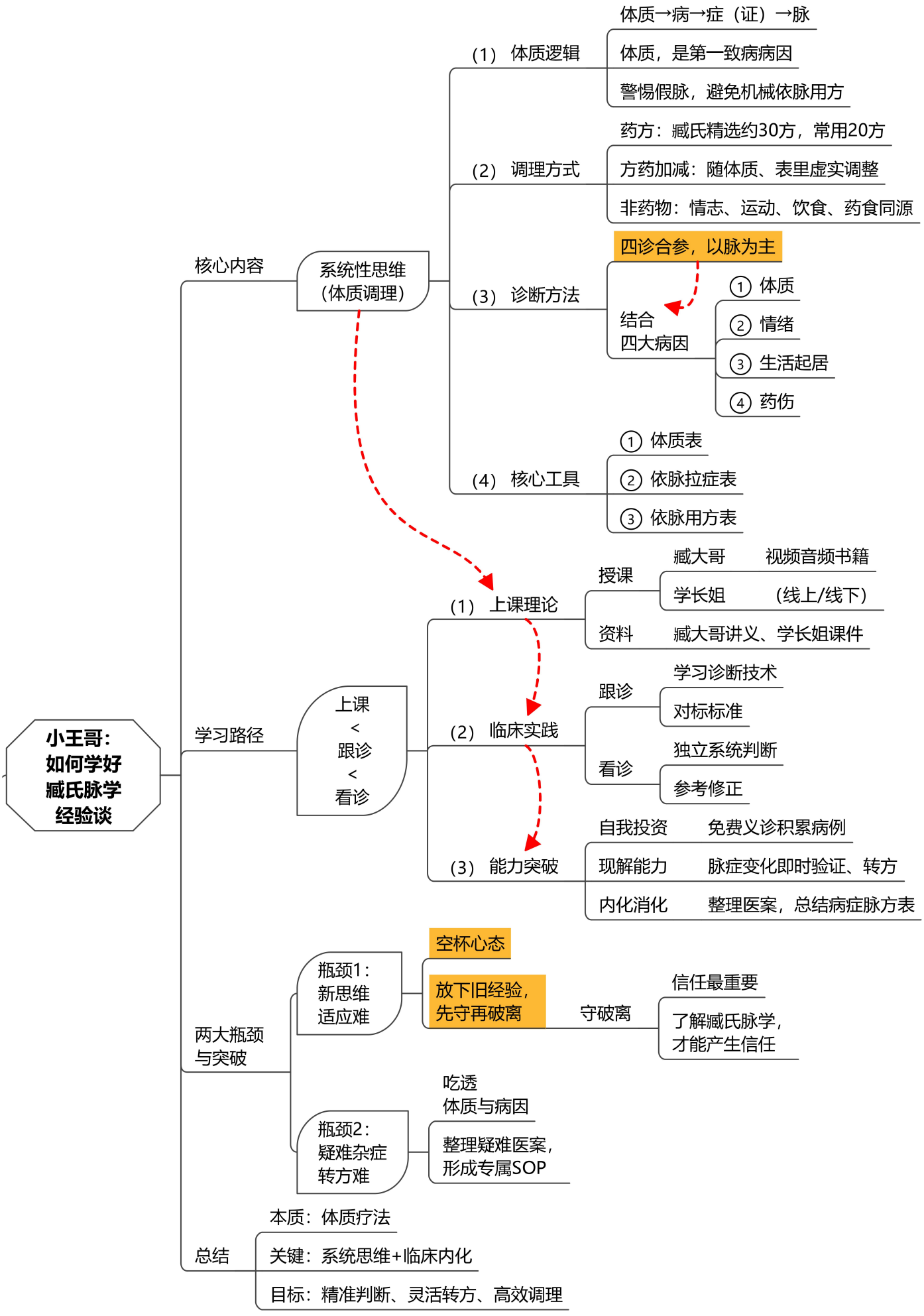
不认可的地方，是什么？

臧大哥对我们的嘱托：

未来可以让我们中国人扬眉吐气的，
就是这套医学！

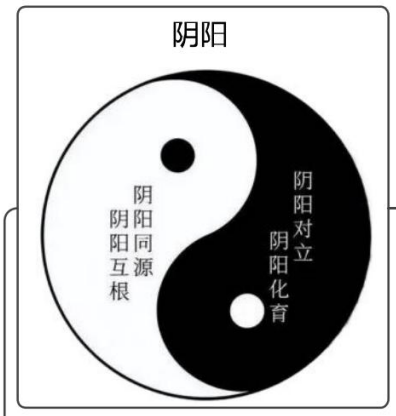
我们大家的力量结合起来，
一定会有这一天！

让我们中国人在整个世界扬眉吐气，
靠各位了！


小王哥：
如何学好
臧氏脉学
经验谈
核心内容
系统性思维
（体质调理）
（1） 体质逻辑
体质→病→症（证）→脉
体质，是第一致病病因
警惕假脉，避免机械依脉用方
（2） 调理方式
药方：臧氏精选约30方，常用20方
方药加减：随体质、表里虚实调整
非药物：情志、运动、饮食、药食同源
（3） 诊断方法
四诊合参，以脉为主
结合
四大病因
① 体质
② 情绪
③ 生活起居
④ 药伤
（4） 核心工具
① 体质表
② 依脉拉症表
③ 依脉用方表
学习路径
上课
<
跟诊
<
看诊
（1） 上课理论
授课
臧大哥 视频音频书籍
学长姐 （线上/线下）
资料
臧大哥讲义、学长姐课件
（2） 临床实践
跟诊
学习诊断技术
对标标准
看诊
独立系统判断
参考修正
（3） 能力突破
自我投资 免费义诊积累病例
现解能力 脉症变化即时验证、转方
内化消化 整理医案，总结病症脉方表
两大瓶颈
与突破
瓶颈1：
新思维
适应难
空杯心态
放下旧经验，
先守再破离
守破离
信任最重要
了解臧氏脉学，
才能产生信任
瓶颈2：
疑难杂症
转方难
吃透
体质与病因
整理疑难医案，
形成专属SOP
总结
本质：体质疗法
关键：系统思维+临床内化
目标：精准判断、灵活转方、高效调理

基础知识

阴阳

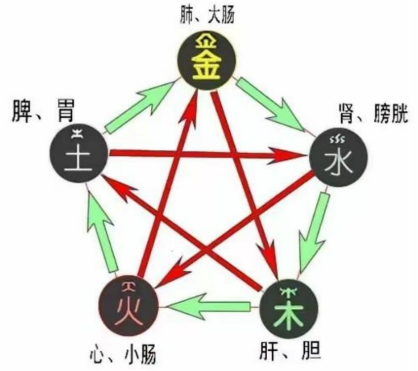


- 《道德经》：
  道生一，一生二，二生三，
  三生万物。
  万物负阴而抱阳。
  - 一：元气
  - 二：阴阳　《医学启源》：一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾
  - 三：阴阳和合
  - 万物：五脏六腑，气血津液，世间万象……
- 《黄帝内经》：
  阴阳者，
  天地之道也，
  万物之纲纪，
  变化之父母，
  生杀之本始。
  - 阴阳的相互作用
    决定了万物的生长和衰亡。
  - 对立制约
    - 阳气主生长、发展；阴气主收藏、消亡。
    - 成为事物变化的动力，调控事物的发展，达到一定的平衡。
  - 互根互用
    - 阳根于阴，阴根于阳
    - 阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。
    - 孤阴不生，孤阳不长
  - 互损
    - 阴损及阳
    - 阳损及阴
    - 阴阳两虚
  - 相互转化
    - 寒极生热，热极生寒
    - 寒极似热，热极似寒
- 《伤寒论》：
  阴阳自和者，
  必自愈
  - 阴胜则阳病，阳胜则热，阳胜则阴病，阴胜则寒
  - 调和阴阳，身体可以自愈
- 八纲辨证
  - 总纲：阴阳
  - 寒热
  - 虚实
  - 表里
- （1）气血
  - 阳：气，能量
    - 气为血之帅
      - 气能生血
      - 气能行血
      - 气能摄血
  - 阴：血，津液
    - 血为气之母
      - 血能养气
      - 血能载气
  - 脾胃气血生化之源，从脾胃下手

本门
(2) 寒热
阳：热，火
阳盛则热（实热） 例如，火大锅热
阴虚则热（虚热） 例如，水少锅热
脉数 浮大
阴：寒，凉
阴盛则寒（实寒） 例如：水多锅冷
阳虚则寒（虚寒） 例如：火小锅凉
脉迟 脉沉
(3) 表里
阳：表 脉浮 阳盛
阴：里 脉沉 阴盛
治法
阳盛（热症）
治阴
真阳病
（真热）
热则寒之
滋阴
参苏 右寸浮大
六神 右关浮大
易简 右三浮大
黄鳖 左关右寸
+双关同治
双关浮大
假阳病
（虚热）
阴虚导致了虚热
（阴虚不能制阳）
补水 补肾水 壮水之主，以制阳光
阴盛（寒症）
治阳
阳虚导致了虚寒
（阳虚不能制阴）
加温
补肾阳 益火之源，以消阴翳
补脾胃
《医方集解》
人身水火，
（阴阳）
原自均平，
它本来是平衡的。
偏者病也，
只要偏了以后，就生病了，
火偏多者，
补水配火，
肾脏是水脏，
能补到肾，就叫补水配火，
不必去火，
去火气，
就是发烧病用苦寒，辛散药。
水偏多者，
补火配水，
加中温
不必去水。
看到这里，
你就知道，
不是臧氏脉学
讲补水配火，
而是古代前辈们
已经研究出来了，
发烧不要用去火的药，
给水来治火，
不伤人又能治本，
这是艺术。

五行

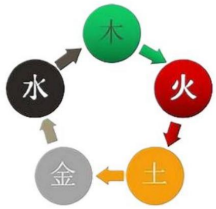
它的基本精神
是说明事物之间
制约和生化关系



臧大哥：
我完全是依据《黄帝内经》里面
所讲的五行相生相克的道理，

如果没有这个道理，
我寸步难行

中医精髓
在五行
相生相克



相邻的
相生

相互依存、促进

生我、我生

母子

生我者，母

我生者，子

母病及子　　子病及母

虚则补其母　　实则泻其子

相隔的
相克

相互制约　　克我、我克　　安相克脏

过度的克　　乘　　木克土

木过强时

土太弱时

比如胃酸

反向的克　　侮　　土克木

木太弱时

土太强时

比如胃炎

五行制化

制化：制约和化生

指五行之间
既相互资生，
又相互制约，

生与克相结合，
自我调节。

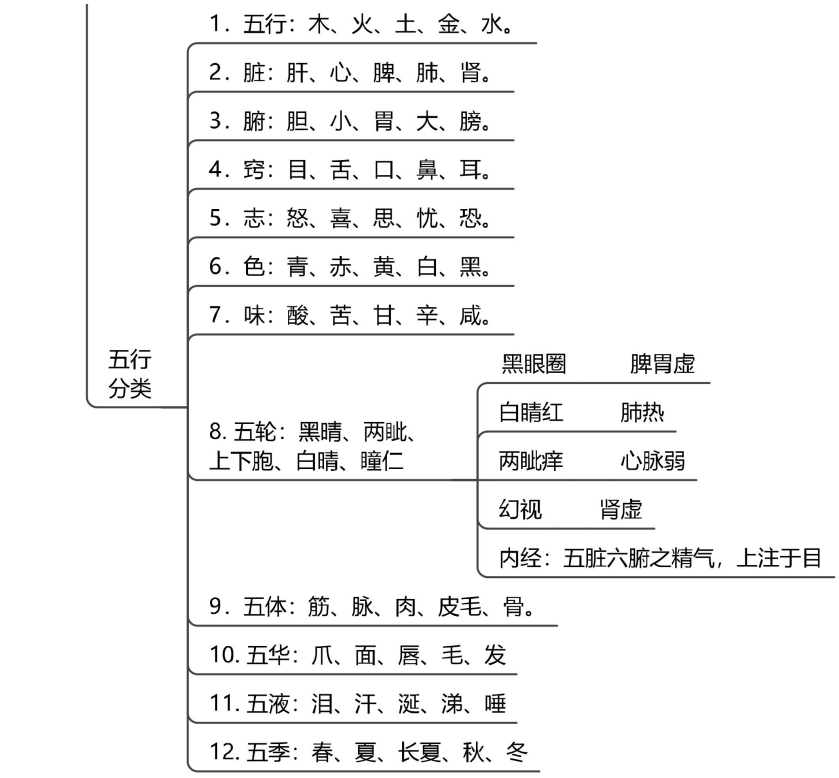
以维持平衡协调，
推动事物间稳定而有序的
变化和发展。

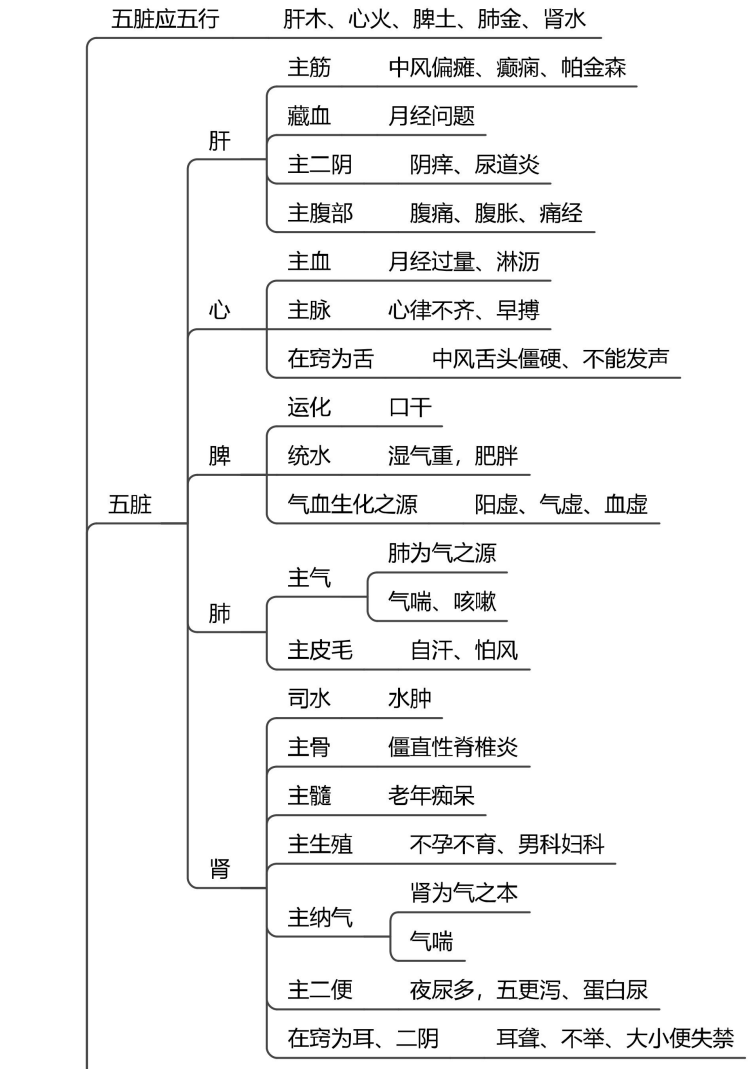
五行相因，
互相提供营养，

一脏衰则循环失序，
慢慢两脏、三脏
接连出问题。

找不到本，
就无法解决问题，

损伤的脏腑，
若不能一并修复，
根本无解，愈治愈糟。


五行分类
1．五行：木、火、土、金、水。
2．脏：肝、心、脾、肺、肾。
3．腑：胆、小、胃、大、膀。
4．窍：目、舌、口、鼻、耳。
5．志：怒、喜、思、忧、恐。
6．色：青、赤、黄、白、黑。
7．味：酸、苦、甘、辛、咸。
8. 五轮：黑睛、两眦、上下胞、白睛、瞳仁
黑眼圈 脾胃虚
白睛红 肺热
两眦痒 心脉弱
幻视 肾虚
内经：五脏六腑之精气，上注于目
9．五体：筋、脉、肉、皮毛、骨。
10. 五华：爪、面、唇、毛、发
11. 五液：泪、汗、涎、涕、唾
12. 五季：春、夏、长夏、秋、冬


五脏
五脏应五行 肝木、心火、脾土、肺金、肾水
肝
主筋 中风偏瘫、癫痫、帕金森
藏血 月经问题
主二阴 阴痒、尿道炎
主腹部 腹痛、腹胀、痛经
心
主血 月经过量、淋沥
主脉 心律不齐、早搏
在窍为舌 中风舌头僵硬、不能发声
脾
运化 口干
统水 湿气重，肥胖
气血生化之源 阳虚、气虚、血虚
肺
主气
肺为气之源
气喘、咳嗽
主皮毛 自汗、怕风
肾
司水 水肿
主骨 僵直性脊椎炎
主髓 老年痴呆
主生殖 不孕不育、男科妇科
主纳气
肾为气之本
气喘
主二便 夜尿多，五更泻、蛋白尿
在窍为耳、二阴 耳聋、不举、大小便失禁
五脏唯脾肾可补，其他以散泻为补
五脏相因
脉浮，有尺脉
养正疾自除

五脏不相因

治则

养子母脏，

培土生金　补脾即是补肺

滋水涵木　滋肾以补肝

益火补土

温心阳补脾阳

温肾阳补脾阳

金水相生

肺阴←→肾阴

宗气←→肾气

安相克脏，

抑木扶土　平肝和胃法　木不乘土

培土制水　温脾治水法　水来土掩

佐金平木　清肺平肝法　佐金以制木

泻火补水　泻南补北法　泻心火补肾水

俟机“散泻和”本脏　浮大时，才能散泻

肝病举例

肝弱者，不能动本脏

养子母脏

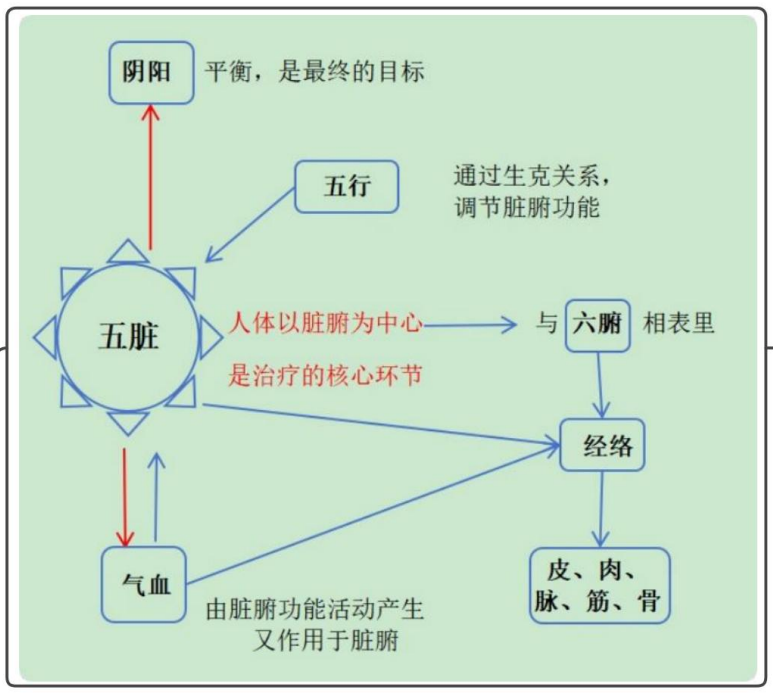
上焦方　养子脏心

下焦方　养母脏肾

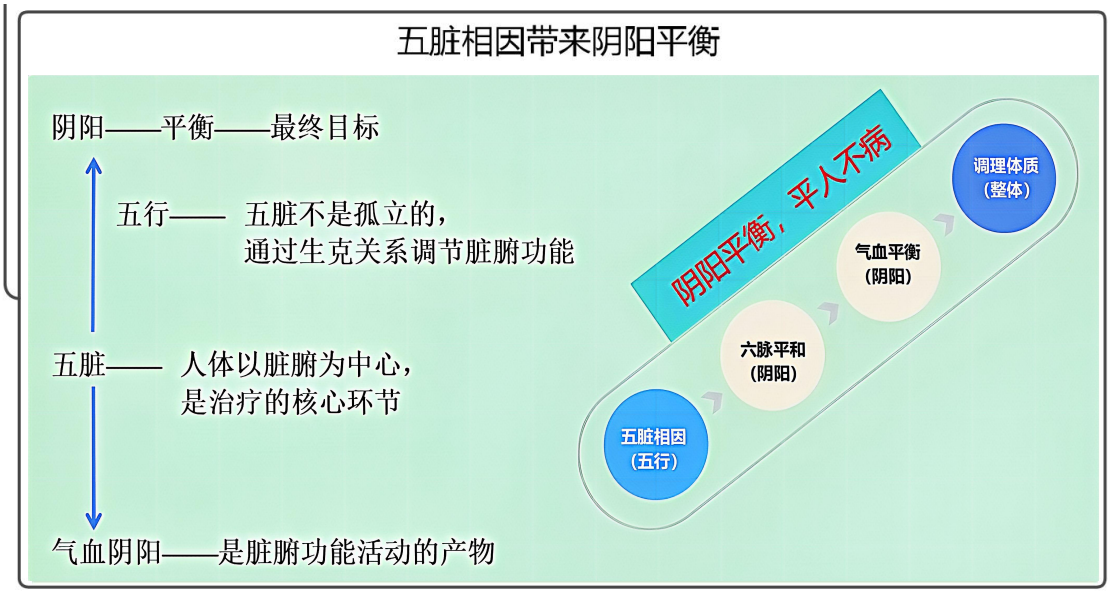
安相克脏　中焦方　安脾胃

补强以后　伺机散泻本脏

五脏为中心



傅教授：
五脏是人体治疗的中心



六淫　　风火暑，湿燥寒

对应五行：木火火，土金水

对应阴阳：阳阳阳，阴阴阴

内不伤
则外不感

《灵枢·百病始生篇》：
卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，
故邪不能独伤人。

内经：

风者，
百病之始也，

风为百病之长，
研习中医若无风之概念，会很难用药，

谁能把人体之风邪驱出，
绝对会有出人头地之时，
终将成为医界之牛耳。

风气大来，木之胜也，
土湿受邪，脾病生焉

风气藏于皮肤之间，内不得通，外不得泄；

风者，善行而数变，腠理开，则洒然寒，闭则热而闷

清静，则肉腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害

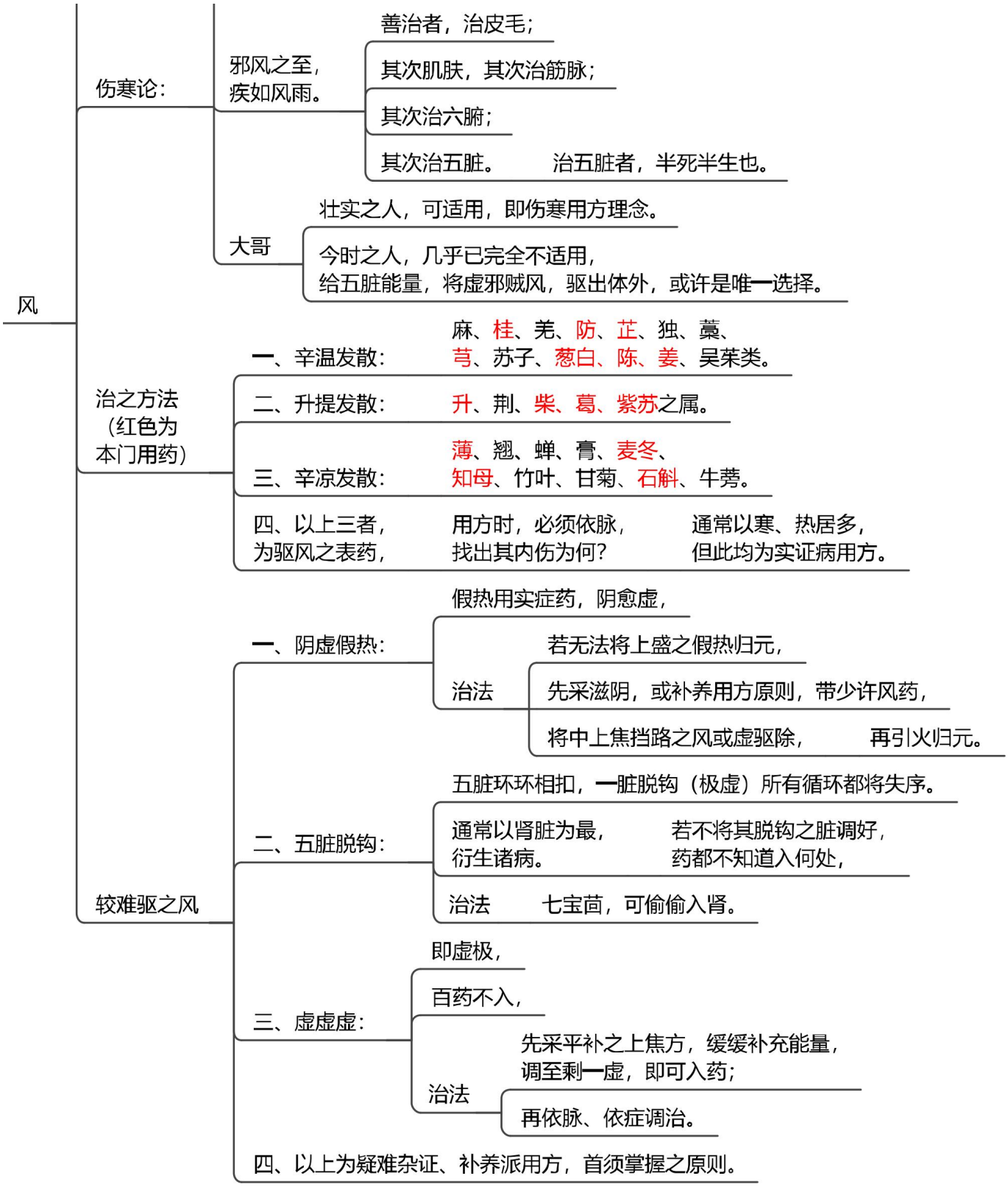
六淫皆得
从风而入。

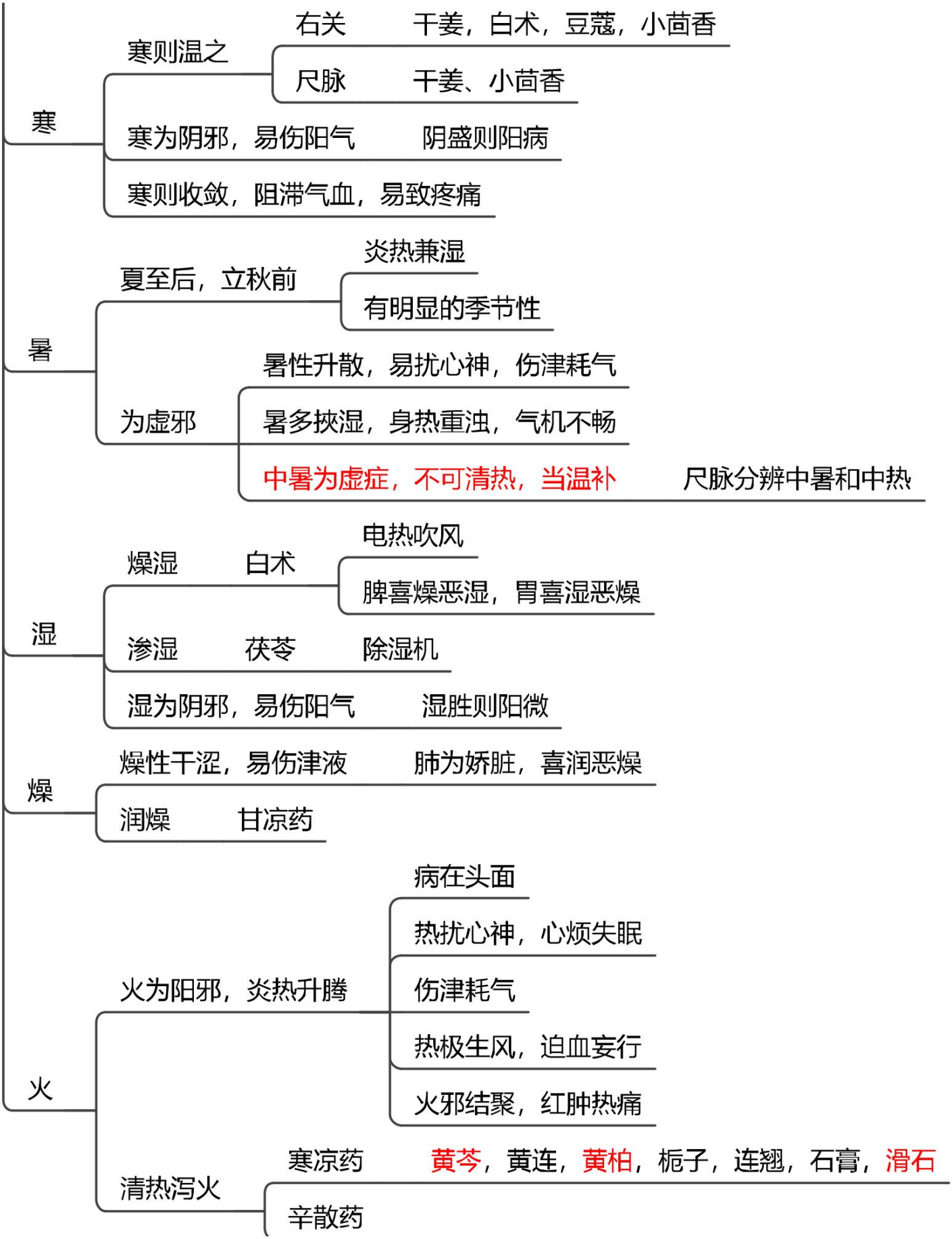
初感毫毛毕直，皮肤闭而热者，宜汗之；

失治不散，渐入经络；

若再失治，则渐入腑、脏。

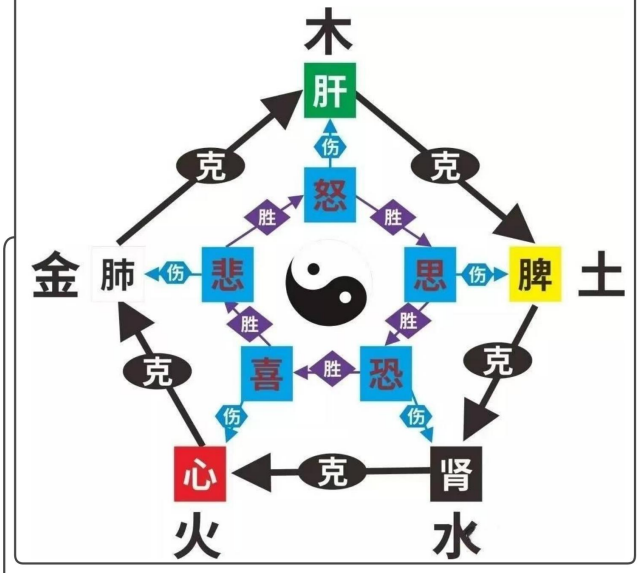
六淫（外感）


风
伤寒论：
邪风之至，疾如风雨。
善治者，治皮毛；
其次肌肤，其次治筋脉；
其次治六腑；
其次治五脏。
治五脏者，半死半生也。
大哥
壮实之人，可适用，即伤寒用方理念。
今时之人，几乎已完全不适用，
给五脏能量，将虚邪贼风，驱出体外，或许是唯一选择。
治之方法（红色为本门用药）
一、辛温发散：
麻、桂、羌、防、芷、独、藁、芎、苏子、葱白、陈、姜、吴茱类。
二、升提发散：
升、荆、柴、葛、紫苏之属。
三、辛凉发散：
薄、翘、蝉、膏、麦冬、知母、竹叶、甘菊、石斛、牛蒡。
四、以上三者，为驱风之表药，
用方时，必须依脉，找出其内伤为何？
通常以寒、热居多，但此均为实证病用方。
较难驱之风
一、阴虚假热：
假热用实症药，阴愈虚，
治法
若无法将上盛之假热归元，
先采滋阴，或补养用方原则，带少许风药，
将中上焦挡路之风或虚驱除，
再引火归元。
二、五脏脱钩：
五脏环环相扣，一脏脱钩（极虚）所有循环都将失序。
通常以肾脏为最，衍生诸病。
若不将其脱钩之脏调好，药都不知道入何处，
治法
七宝茴，可偷偷入肾。
三、虚虚虚：
即虚极，
百药不入，
治法
先采平补之上焦方，缓缓补充能量，调至剩一虚，即可入药；
再依脉、依症调治。
四、以上为疑难杂证、补养派用方，首须掌握之原则。

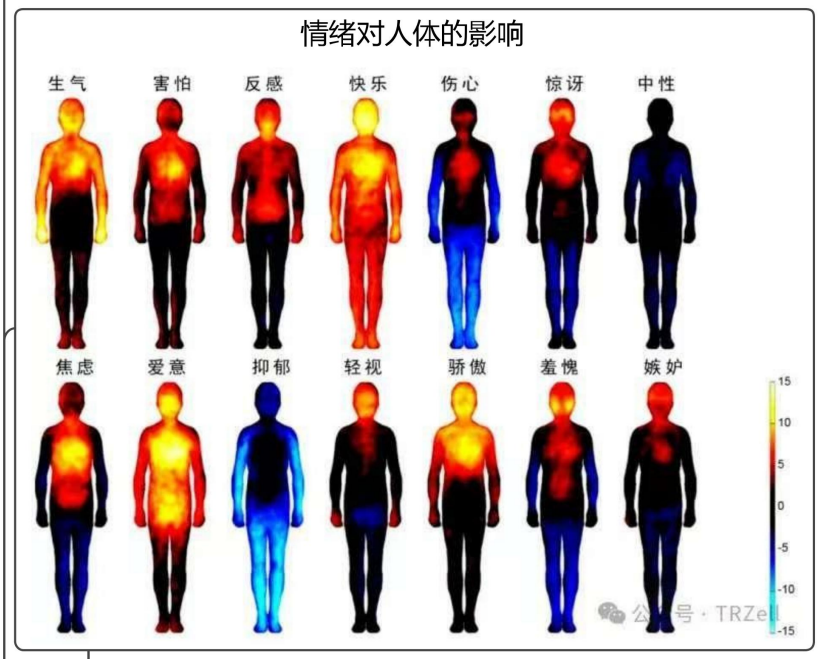

寒
寒则温之
右关 干姜，白术，豆蔻，小茴香
尺脉 干姜、小茴香
寒为阴邪，易伤阳气 阴盛则阳病
寒则收敛，阻滞气血，易致疼痛
暑
夏至后，立秋前
炎热兼湿
有明显的季节性
为虚邪
暑性升散，易扰心神，伤津耗气
暑多挟湿，身热重浊，气机不畅
中暑为虚症，不可清热，当温补 尺脉分辨中暑和中热
湿
燥湿 白术
电热吹风
脾喜燥恶湿，胃喜湿恶燥
渗湿 茯苓 除湿机
湿为阴邪，易伤阳气 湿胜则阳微
燥
燥性干涩，易伤津液 肺为娇脏，喜润恶燥
润燥 甘凉药
火
火为阳邪，炎热升腾
病在头面
热扰心神，心烦失眠
伤津耗气
热极生风，迫血妄行
火邪结聚，红肿热痛
清热泻火
寒凉药 黄芩，黄连，黄柏，栀子，连翘，石膏，滑石
辛散药

七情（1）

五志、五脏、五行
对应关系



情绪对人体的影响



情绪	身体体感特征	背后的生理逻辑
快乐	全身大面积红黄色，从头到脚都有强烈激活	交感神经兴奋，全身血液循环加快，就是我们常说的“浑身暖洋洋”的幸福感
生气 / 焦虑	胸口和头部大面积发红，四肢发黑 / 偏蓝	血液涌向核心器官和头部（为“战斗”准备），导致手脚供血不足、冰凉
伤心 / 抑郁	胸口偏红，但四肢大面积蓝色	核心情绪引发的生理反应集中在胸腔（如胸闷），但整体行动力、身体活力显著下降
爱意 / 骄傲	胸口和上半身大面积红黄色，传递温暖、自信的体感	催产素、多巴胺分泌带来的愉悦感，集中体现在心脏和躯干区域
中性	几乎全黑，代表身体无明显体感变化	作为对照组，和其他情绪形成鲜明对比

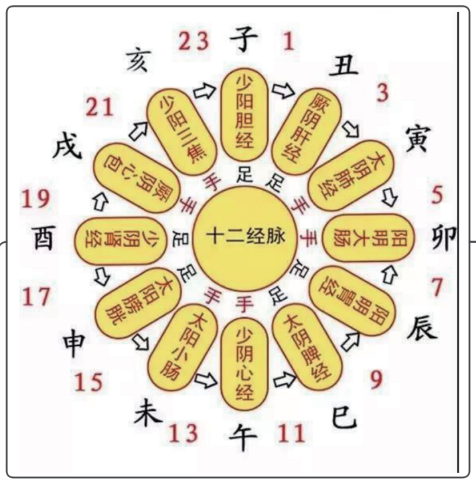
七情
（内伤）

- 说明
  - 情绪和身体的关联
    有很强的生物学基础
  - 这张图印证了常说的 “身体比大脑更懂情绪”：
    比如害怕时 “手脚冰凉”、
    伤心时 “心都碎了”、
    生气时 “火冒三丈”，
    这些日常感受，都能在热力图中找到对应的生理映射。
  - 它打破了 “情绪是纯心理活动” 的认知，
    说明情绪和身体是不可分割的整体，
    很多时候身体的不适（如莫名的胸闷、乏力），
    可能是未被察觉的情绪在 “发声”。

五志

- 怒
  - 怒则气上，过怒伤肝
    - 头胀头痛，面红眼赤
    - 横逆犯脾，腹痛腹泻
- 喜
  - 喜则气缓，过喜伤心
    - 心气涣散，心神错乱
  - 喜乐者，神惮散而不藏
    - 范进中举，心神癫狂。
    - 岳父耳光，以恐胜喜。
- 思
  - 思则气结，
    过思伤脾
    - 运化失职
    - 食少，腹胀，便溏
    - 心悸，失眠，多梦
    - 萎靡，倦怠乏力
  - 思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结。
- 忧
  - 忧和思常在一起
  - 忧思气结，过忧伤肺
    - 肺失宣降、肺气耗伤
    - 气短胸闷，乏力懒言
    - 意志消沉，精神不振
- 恐
  - 恐则气下，过恐伤肾
    - 肾气失固，气陷于下
    - 二便失禁，遗精滑精骨痿
- 悲
  - 悲则气消，五脏都伤
    - 忧悲伤肺，肺气耗伤
    - 气短胸闷，乏力懒言
    - 意志消沉，精神不振
- 惊
  - 惊则气乱

十二时辰



- 服药
  - 早上　脾胃药
  - 中午　心药
  - 傍晚　肾药
  - 睡前　心药
- 发病
  - 睡中醒
  - 晚上重
    - 是肝的问题
    - 肝胆经

- 养生
  - 饮食　早饭更重要
  - 睡眠　子午觉
    - 子时应眠
      - “凡十一脏取决于胆”《素问·六节藏象论》。
      - 李时珍曰：“胆，属木，为少阳相火，发生万物，为决断之官，十一脏之主。”
    - 午时心火最旺
      - 睡眠补充肾水
      - 水火既济

本门主要关注的内伤：　寒　热　虚

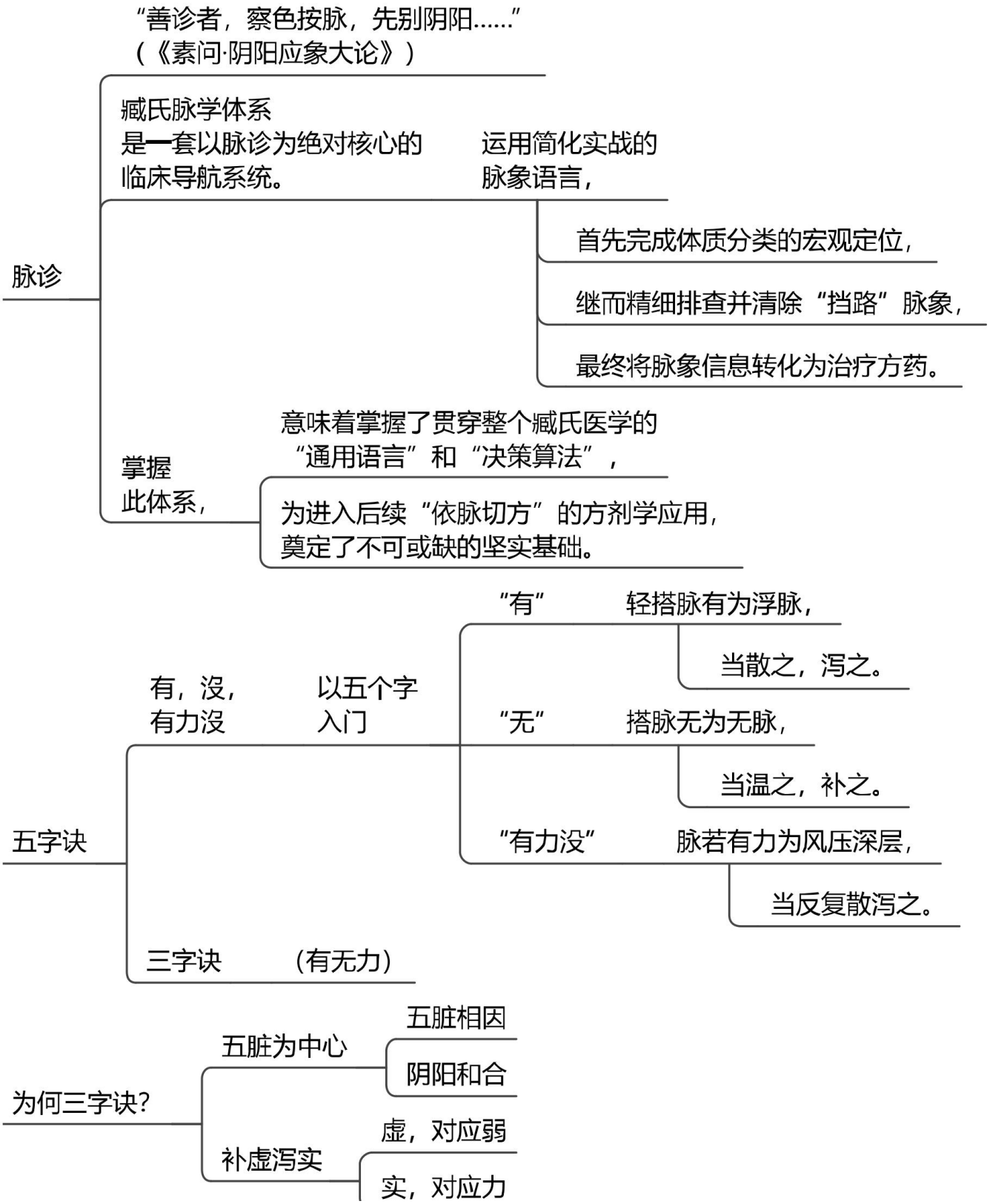
生病和疗病的过程

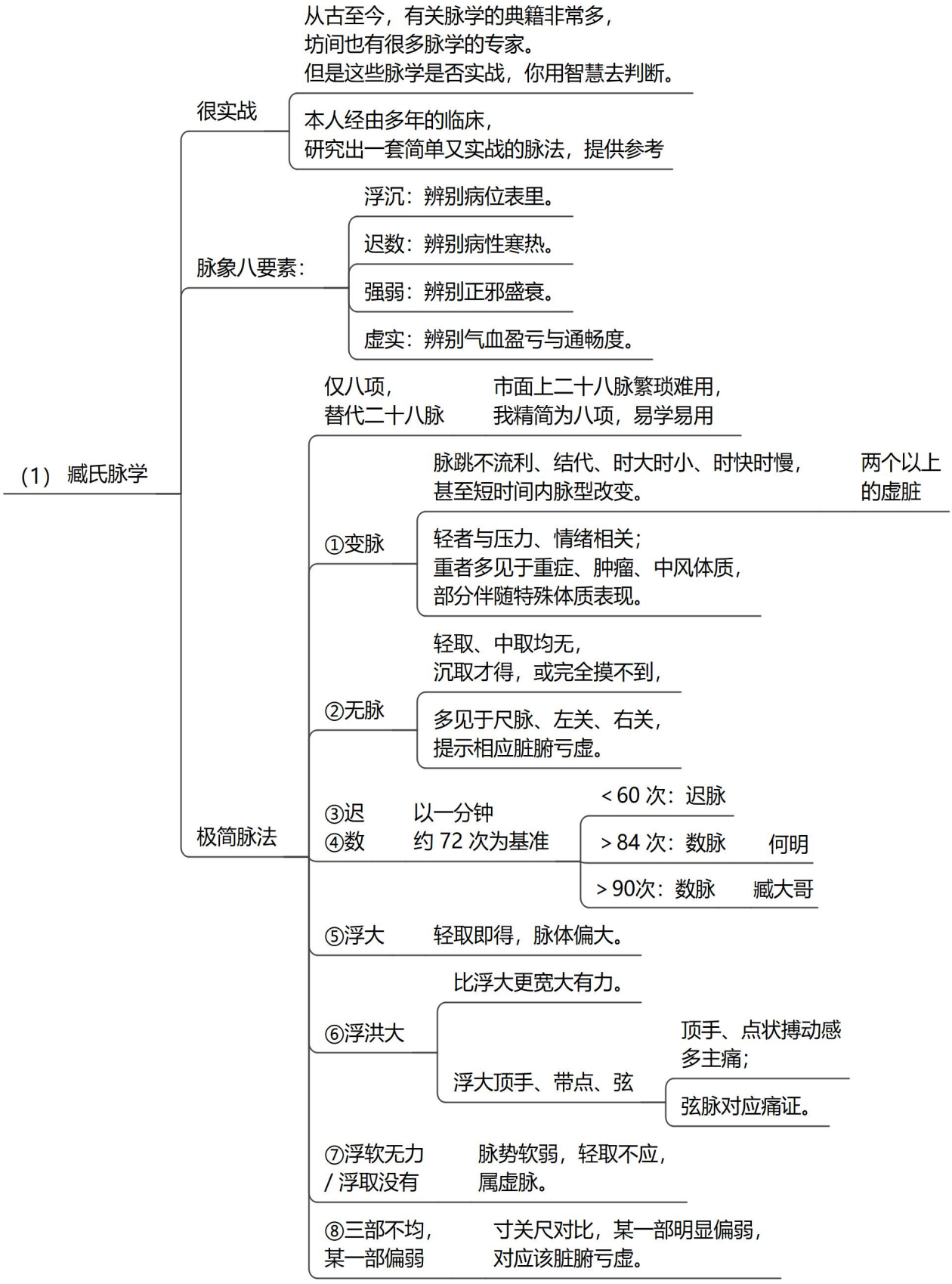
- 生病　内不伤则外不感　素问
  - 风雨寒热，不得虚邪，不能独伤人；
    - 虚
      - 不是“虚弱”，而是：
      - 非时、不正：和季节、方位不合（如春行西风、夏行北风）；
      - 乘虚而入：必须等人体正气“虚”（不足、失守）才会伤人；
    - 邪　不正之气、致病因素（风、雨、寒、热等）
  - 卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人。
  - 此必因虚邪之风，与其身形，两虚相得，乃客其形。
    - 虚邪之风（外虚） + 身形之虚（内虚） = 两虚相得，邪气才能侵入身体（客其形）
- 疗病
  - 驱内伤，则外感无所附
    - 驱内伤
      - 寒　寒则温之
      - 热　热则凉之
      - 虚　虚则补之
    - 外感　风　散药 + 正气
      - 虚人　芪艽葛苏葱
      - 壮人　麻黄、羌活、独活、荆芥、防风

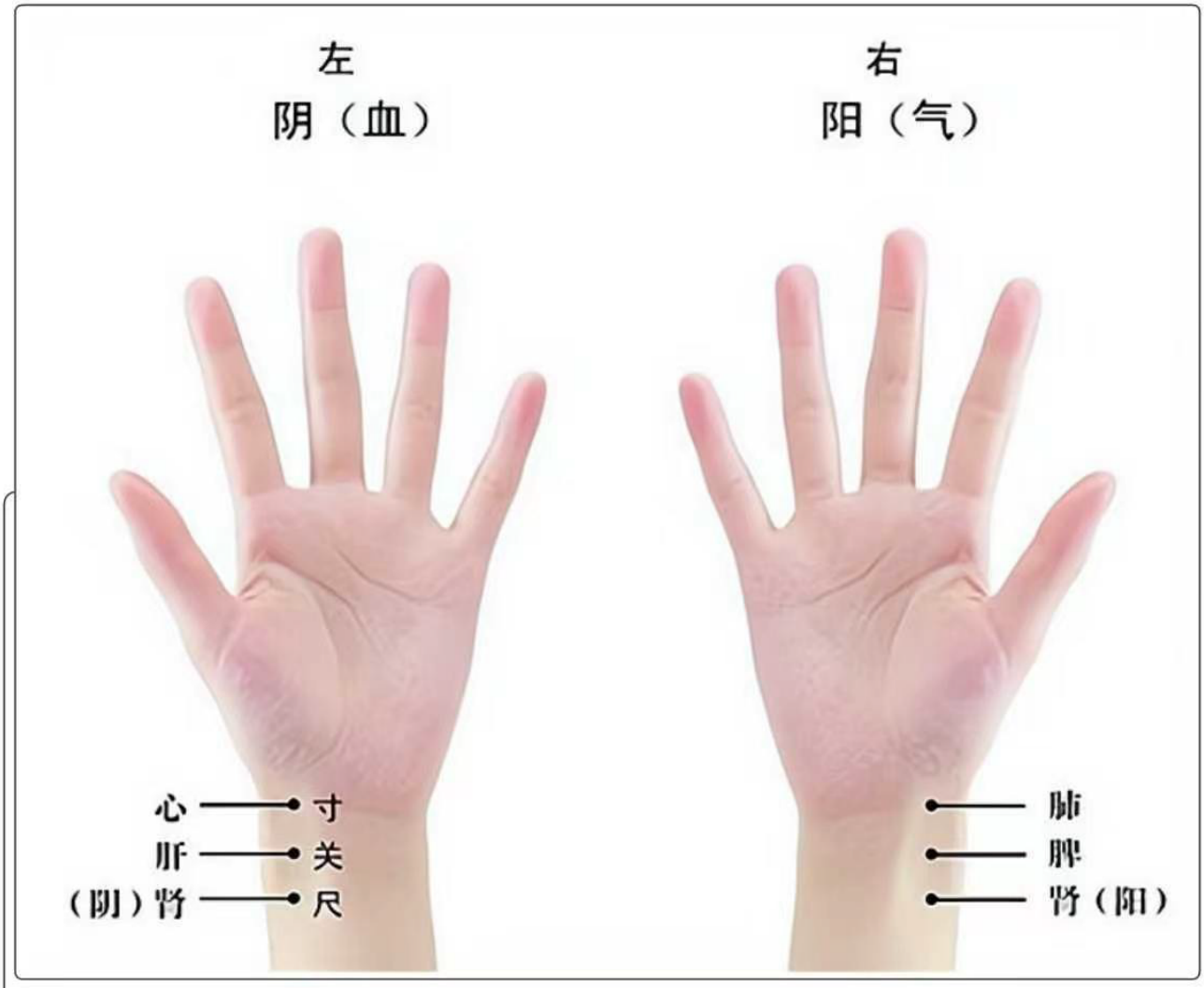
- 臧氏脉学治病理念
  - **臧氏脉学，是一套“调理体质”的临床体系**
    - 其自我定位超越了常规的“辨证论治”。
    - 它反复强调自身是“一套严谨的系统体质调治法”。
    - 其所有理论构建与临床操作，最终都指向一个根本目标：
      - 修复被现代生活方式及不当治疗所损伤的人体根本（尤其是脾肾），
      - 恢复五脏之间正常的能量循环（五行相因），从而达到“调理体质，治着病”的深层疗效。
      - 一种从“治病”到“治人”、从“对症”到“对质”的根本转换。
  - **臧氏核心病机观**
    - 现代人的疾病，尤其是慢性病、疑难病，
      - 多非一脏孤立受损，
      - 而是起始于关键脏器的虚损（尤以肾虚为始），
      - 导致整个五行生克链条破坏，
      - 形成“一脏衰则循环失序”的全身性问题。
    - 因此，治疗必须着眼于恢复五脏间的“相因”关系。
  - **致病因由**
    - 内伤为体，外感为标
      - 本体系对病因的认知，彻底贯彻了“内不伤则外不感”的思想，将体质内因置于绝对优先地位。
      - 内因
        - 七情、饮食不节（过食寒凉、膏粱厚味）、房劳过度、久病及误治（特别是滥用苦寒、辛散、攻下药物），
        - 这些是导致脾肾虚损、正气（能量）不足的根本原因。
        - 正虚则内生痰湿、瘀血等病理产物。
      - 外因
        - 六淫（风、寒、暑、湿、燥、火）邪气。
        - 其中“风为百病之长”，外感病症多以风邪为先导。
        - 但外邪能否致病，完全取决于内在体质是否“虚”而“留有空位”。
        - 一个脾肾功能强健、气血充沛的人，不易被外邪侵袭，即使受邪也易自愈或速愈。
      - 因此，诊断与治疗的首要任务，
        - 是辨识并修复内在的虚损体质（尤其是脾肾），
        - 而非仅仅对抗外来的邪气或表面的症状。

- **治病总则**
  - 扶正为本，五行为径
    - 病症是表，本在五脏
    - 养正积自除
  - 扶正→祛邪
    - 通过补养脾肾，为五脏补充核心能量，使人体自身恢复驱邪、化瘀、散热的能力。
    - 这比直接使用祛邪药物（如清热、攻下、发散）更为根本和安全，避免“治标伤本”。
    - “加固城墙”
      - 现代人十有八九底子虚，像座年久失修的老城，
      - 城门（抵抗力）本来就松，你还开门出去跟敌人（病毒）干架，那不是找死吗？
      - 不如关起门来，赶紧修城墙、屯粮草（补脾肾），
      - 等城固若金汤了，“隔壁老王”（病毒、风邪）在门口溜达半天进不来，自己就走了。
      - 这叫“正气存内，邪不可干”。
    - 韬光养晦
      - 内虚 + 外扰 = 一触即溃、一病就重。
      - 国家面对外部势力，如果内部不稳、民生不宁、经济虚弱、人心涣散，还高调出去硬扛，只会越打越累、越耗越虚，最后被拖垮。
      - 真正高明的做法，是韬光养晦、关门固本、强基固本：
      - 稳住内部、发展经济、改善民生、凝聚人心（补脾肾、养气血、固正气）
      - 加固城防、修好城墙、屯足粮草、练强兵马（增强免疫力、修复体质、恢复精力）
      - 对外示弱、守而不战、避免消耗（少熬夜、少劳累、少焦虑、少纵欲、少外感）
      - 等到综合实力雄厚、国防坚固、经济稳健、社会安定之后：外邪自己撤退了、自己消失了。
      - 这就是：
      - 中医讲的：正气存内，邪不可干
      - 国家战略讲的：固本强基，韬光养晦；内圣外王，不战而胜
  - 核心策略
    - 养子母脏：
      - 通过滋补本脏的“母脏”来间接补充本脏能量；
      - 通过调理“子脏”来调节本脏的能量。
    - 安相克脏：在调理本脏时，同时安抚与之有相克关系的脏腑，以维持系统稳定，防止治疗引起新的失衡。
    - 俟机散泻本脏：待本脏能量得到补充，实证显现（如脉由弱转浮大）时，再适时运用散法或泻法，清除本脏的郁滞或实邪。
  - 最高目标：治未病。
    - 秉承 “圣人不治已病治未病” 的理念。
    - 此处的“治未病”不仅是预防疾病发生，
    - 更是在治疗已病时通过修复体质（脾肾），阻断疾病在五脏间传变的路径，防止其深入或引发其他关联疾病。

- 古中医脉学
  - 最早脉学记载　战国扁鹊的《难经》
  - 后来较有名气的有——
    - 晋王叔和的“脉经”、
    - 明李时珍的“濒湖脉学”，
    - 及清医宗金鉴“四诊心法”，
    - 近期中医诊断学“称 28 脉”。
  - 以上各书曾经均熟读，少时濒湖脉学，全本背下，
    - 但完全不实战，与病人交流不上，
    - 在用方上仅能跟风寒、火玩一玩，
    - 真没有成就感
  - 傅教授
    - 中医诊断学讲到脉诊，
      - 有分述历代各家对脉学的分部的看法，分得很详细，
      - 但在中医诊断学辨证部分，就不见它了，　所有的脉都是笼统的摸脉；
      - 到了临床，各科更是如此——
        - 要么就写个脉滑，
        - 要么写个脉弦，
        - 要么写个脉细，
        - 从来不分部位。
      - 非常可惜——
        - 它失去了中国传统医学很多很宝贵的东西，
        - 但是至今我们的教材还是这样。
    - 可臧老师不是，
      - 他用六部分脉的方法来诊脉，
      - 同时是可以验证到它的变化，有的时候就是如鼓应桴——就那个现解，马上就改变。
      - 很多人都说中医的效果很慢，其实不是这个样子的，中医要是效果快的话，在分秒之间就变化了。
    - 臧老师以他实际的医术能力征服了我，
      - 所以我觉得臧老师这一套方法，在今天这个时代很难能可贵——
      - 真正地继承了中医传统医学本来的精髓，可贵就在这里。
      - 所以恭喜同学们，你们真是有福了！

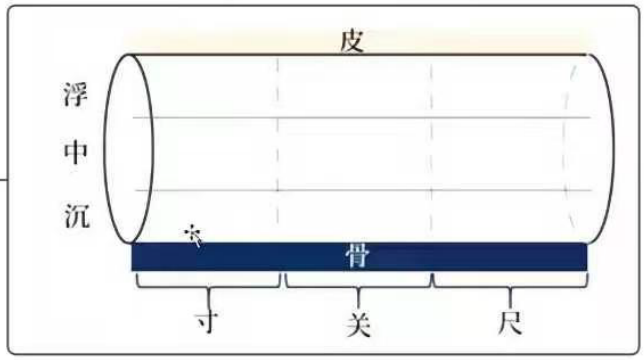

“善诊者，察色按脉，先别阴阳……”
（《素问·阴阳应象大论》）
脉诊
臧氏脉学体系
是一套以脉诊为绝对核心的
临床导航系统。
运用简化实战的
脉象语言，
首先完成体质分类的宏观定位，
继而精细排查并清除“挡路”脉象，
最终将脉象信息转化为治疗方药。
掌握
此体系，
意味着掌握了贯穿整个臧氏医学的
“通用语言”和“决策算法”，
为进入后续“依脉切方”的方剂学应用，
奠定了不可或缺的坚实基础。
五字诀
有，没，
有力没
以五个字
入门
“有”
轻搭脉有为浮脉，
当散之，泻之。
“无”
搭脉无为无脉，
当温之，补之。
“有力没”
脉若有力为风压深层，
当反复散泻之。
三字诀
（有无力）
为何三字诀？
五脏为中心
五脏相因
阴阳和合
补虚泻实
虚，对应弱
实，对应力


从古至今，有关脉学的典籍非常多，
坊间也有很多脉学的专家。
但是这些脉学是否实战，你用智慧去判断。
（1） 臧氏脉学
很实战
本人经由多年的临床，
研究出一套简单又实战的脉法，提供参考
脉象八要素：
浮沉：辨别病位表里。
迟数：辨别病性寒热。
强弱：辨别正邪盛衰。
虚实：辨别气血盈亏与通畅度。
极简脉法
仅八项，
替代二十八脉
市面上二十八脉繁琐难用，
我精简为八项，易学易用
①变脉
脉跳不流利、结代、时大时小、时快时慢，
甚至短时间内脉型改变。
两个以上
的虚脏
轻者与压力、情绪相关；
重者多见于重症、肿瘤、中风体质，
部分伴随特殊体质表现。
②无脉
轻取、中取均无，
沉取才得，或完全摸不到，
多见于尺脉、左关、右关，
提示相应脏腑亏虚。
③迟
④数
以一分钟
约 72 次为基准
＜60 次：迟脉
＞84 次：数脉
＞90次：数脉
何明
臧大哥
⑤浮大
轻取即得，脉体偏大。
⑥浮洪大
比浮大更宽大有力。
浮大顶手、带点、弦
顶手、点状搏动感
多主痛；
弦脉对应痛证。
⑦浮软无力
/ 浮取没有
脉势软弱，轻取不应，
属虚脉。
⑧三部不均，
某一部偏弱
寸关尺对比，某一部明显偏弱，
对应该脏腑亏虚。

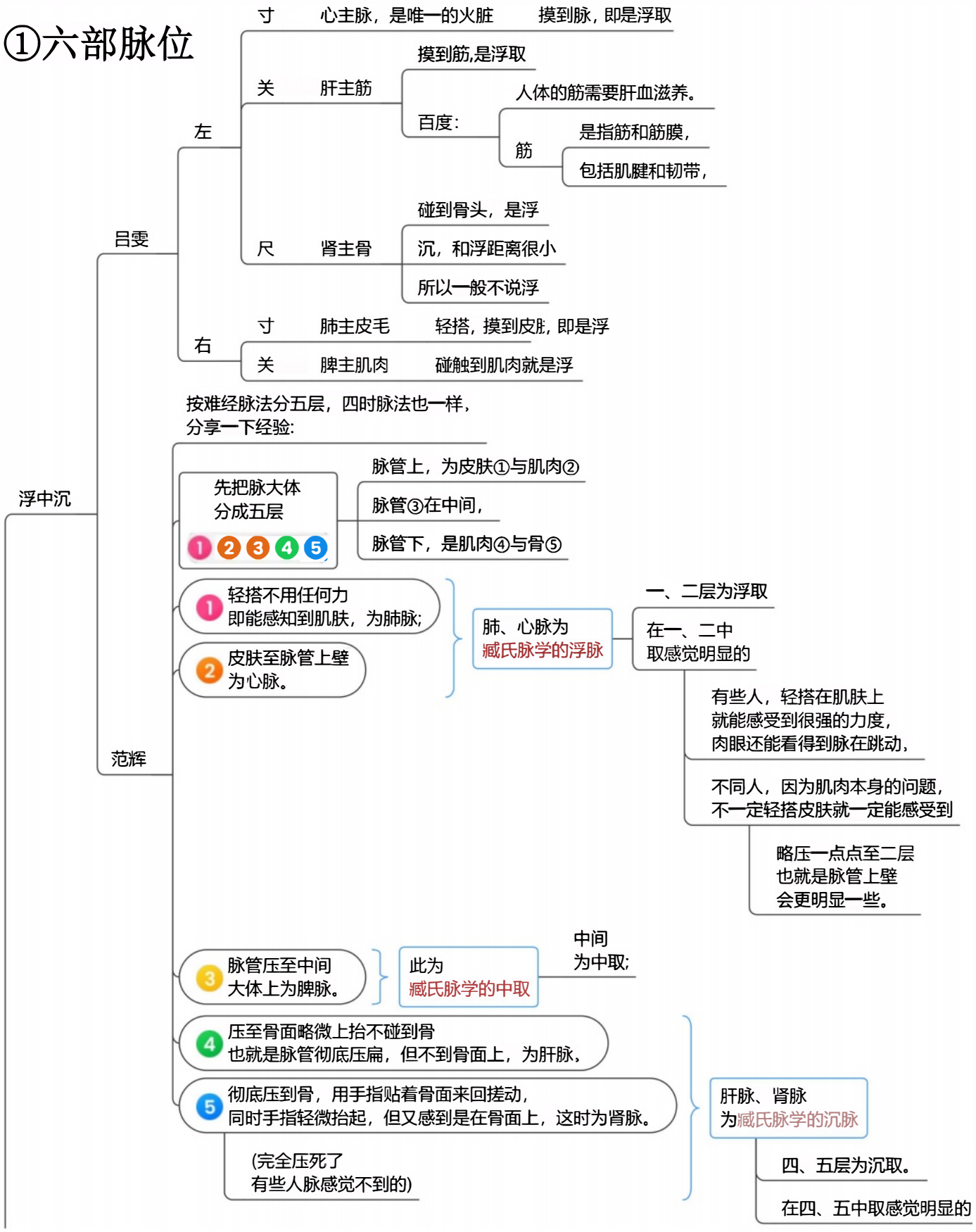


大分

- 定位方法
  - A.先定寸
    - 寸 第一腕横纹下面
    - 关 同身寸下面
    - 尺 关下面
  - B.先定关
    - 关 高骨下缘
    - 寸 关之上
    - 尺 关之下
- 浮中沉

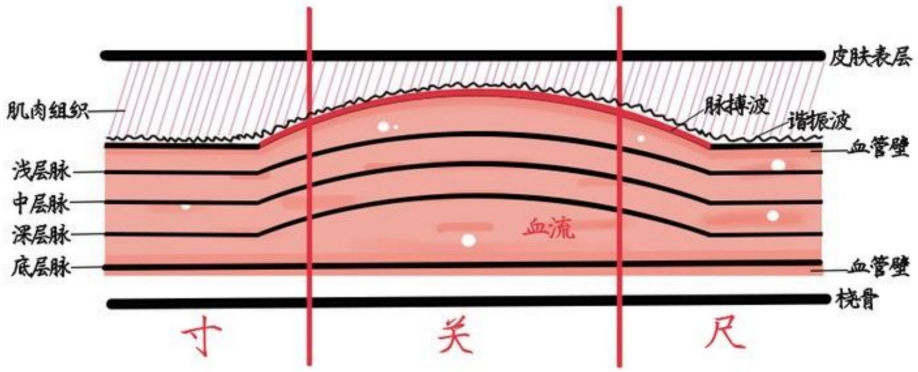


①六部脉位

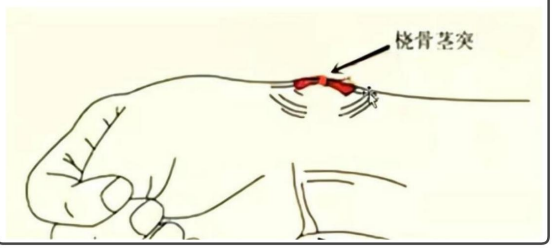

浮中沉
吕雯
左
寸 心主脉，是唯一的火脏 摸到脉，即是浮取
关 肝主筋
摸到筋,是浮取
百度:
人体的筋需要肝血滋养。
筋
是指筋和筋膜，
包括肌腱和韧带，
尺 肾主骨
碰到骨头，是浮
沉，和浮距离很小
所以一般不说浮
右
寸 肺主皮毛 轻搭，摸到皮肤，即是浮
关 脾主肌肉 碰触到肌肉就是浮
范辉
按难经脉法分五层，四时脉法也一样，
分享一下经验:
先把脉大体
分成五层
1 2 3 4 5
脉管上，为皮肤①与肌肉②
脉管③在中间，
脉管下，是肌肉④与骨⑤
1 轻搭不用任何力
即能感知到肌肤，为肺脉;
2 皮肤至脉管上壁
为心脉。
肺、心脉为
臧氏脉学的浮脉
一、二层为浮取
在一、二中
取感觉明显的
有些人，轻搭在肌肤上
就能感受到很强的力度，
肉眼还能看得到脉在跳动，
不同人，因为肌肉本身的问题，
不一定轻搭皮肤就一定能感受到
略压一点点至二层
也就是脉管上壁
会更明显一些。
3 脉管压至中间
大体上为脾脉。
此为
臧氏脉学的中取
中间
为中取;
4 压至骨面略微上抬不碰到骨
也就是脉管彻底压扁，但不到骨面上，为肝脉。
5 彻底压到骨，用手指贴着骨面来回搓动，
同时手指轻微抬起，但又感到是在骨面上，这时为肾脉。
(完全压死了
有些人脉感觉不到的)
肝脉、肾脉
为臧氏脉学的沉脉
四、五层为沉取。
在四、五中取感觉明显的

细分

一般中医，高骨定关（非本门）



本门定位：
高骨茎突是寸关的分界



寸关尺

臧大哥
- ① 先定寸脉 第一腕横纹 齐平食指上侧
- 依次定关脉 医书上都是说高骨定关
  - 但是高骨位置不一样
- 尺脉
  - 无名指试尺脉准确度不够
  - 用中指来试尺脉，这样子稳定度就够了

赵医师介绍臧大哥 ① 但是斜放 所以差不多是②

芮载义 ① 第一腕横纹

王雅秀 ① 第二腕横纹（上下寻找清晰点）

傅老师 ④ 转圈通透的腕横纹
- 是寸
- 可能是
  - 第二横纹
  - 第三横纹

郭海燕 ①
- 第一腕横纹下，宽1.5寸是寸
- 高骨下沿是关

小王哥 ① 第一腕横纹下缘是寸

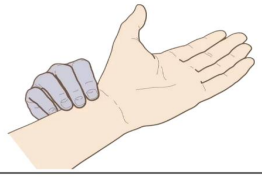
吕院长 ② 高骨下沿定关

何明
- ① 第一腕横纹
- ② 或者挠骨茎突 在寸关之间
- ③ 或者食指 压在第二腕横纹上

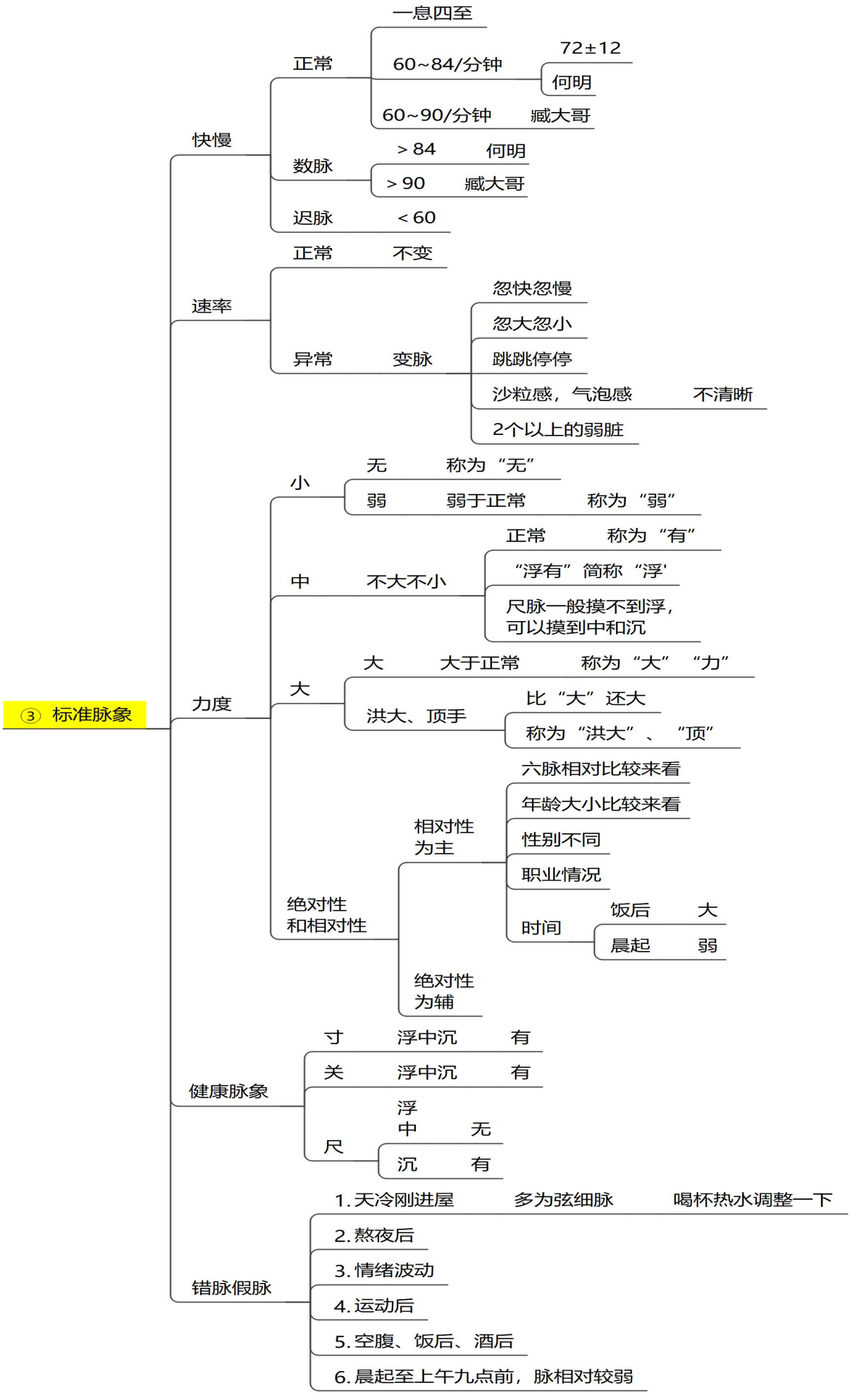
李志贞 ①和②同时采用

讨论： 寸关尺，到底在哪里？

- ② 摸脉方法
  - 环境：安静
  - 患者体位
    - 坐位或卧位，
      - 低于心的位置
      - 坐姿最准，其次卧姿
    - 手臂平伸，掌心向上，
      - 手肘手腕手掌放平
      - 自己给自己把脉时，肘部不能过度弯曲，会压住脉



    - 手腕手肘稳定，要有依托　手腕下脉枕至最放松高度。
  - 医者姿势
    - 四定点
      - 1. 定点一　医者掌根　放在患者腕旁脉枕上。
      - 2. 定点二　医者手腕　与脉枕接触点稳定。
      - 3. 定点三　医者前臂　稳定放于诊桌上。
      - 4. 定点四　医者肘关节　稳固接触桌面。
    - 一辅助　医者另一只手轻握患者手背/手心，以稳定患者并探查手温。
  - 定位
    - ① 1. 确立基准　以患者手腕第一道横纹为起始参考线
    - ② 2. 先定寸位　用食指指腹沿腕横纹附近上下微移，探寻并固定脉搏跳动最清晰、最适宜的点。
    - ③ 3. 再定关尺　寸位定住后，中指自然放下即为关部，无名指自然放下即为尺部。
      - 同身寸
      - 三指需并拢呈弓形，指腹平贴皮肤，
      - 此为总按
  - 布指
    - 1. 用指腹　使用指腹（指尖与指纹之间）扣脉，此处感觉最为敏锐。
    - 2. 同身寸　以被摸者的同身寸布指
      - 身高臂长的，布指疏
      - 身矮臂短者，布指密
    - 3. 尺微调　无名指探查尺脉，不够清晰，可“中指下移一格”来感知，以增强诊察的准确性。
  - 先总按　好处
    - 脉跳力度大　容易摸到脉
    - 容易辨别三部脉的差别
  - 再单按
    - 单按顺序
      - 浮先摸　皮肤下面，1毫米左右
      - 再摸沉　按到骨头，稍稍上抬一点点
      - 最后中　浮和沉中间部位
    - 1、浮　切入皮肤1毫米左右
    - 2、沉　用力按到桡骨边，再退回来一点点，若即若离。
    - 3、中　从沉退到浮和沉之间


③ 标准脉象
快慢
正常
一息四至
60~84/分钟
72±12
何明
60~90/分钟
臧大哥
数脉
＞84
何明
＞90
臧大哥
迟脉
＜60
速率
正常
不变
异常
变脉
忽快忽慢
忽大忽小
跳跳停停
沙粒感，气泡感
不清晰
2个以上的弱脏
力度
小
无
称为“无”
弱
弱于正常
称为“弱”
中
不大不小
正常
称为“有”
“浮有”简称“浮'
尺脉一般摸不到浮，
可以摸到中和沉
大
大
大于正常
称为“大”“力”
洪大、顶手
比“大”还大
称为“洪大”、“顶”
绝对性
和相对性
相对性
为主
六脉相对比较来看
年龄大小比较来看
性别不同
职业情况
时间
饭后
大
晨起
弱
绝对性
为辅
健康脉象
寸
浮中沉
有
关
浮中沉
有
尺
浮
中
无
沉
有
错脉假脉
1. 天冷刚进屋
多为弦细脉
喝杯热水调整一下
2. 熬夜后
3. 情绪波动
4. 运动后
5. 空腹、饭后、酒后
6. 晨起至上午九点前，脉相对较弱

④ 脉象记录

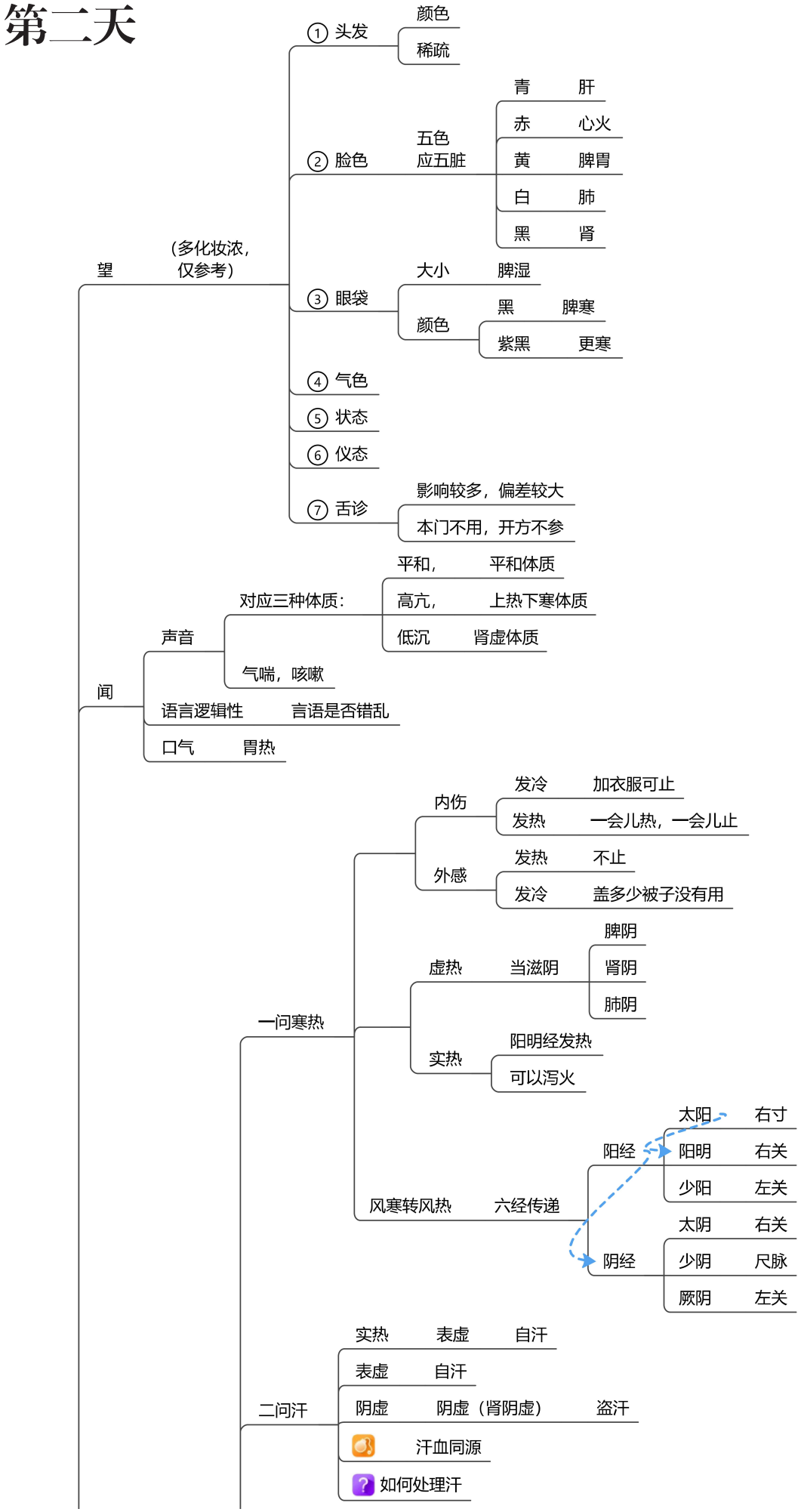
- 脉点
  - 14个（左右各7）
    - 寸：浮中沉取3、关：浮中沉取3、尺：沉取1
      - 共7个脉点
      - 双手14个脉点
- 符号
  - 主要脉象
    - 无（小）：0或-
    - 有（中）：+，±
    - 力（大）：++，±±，↑
  - 全部脉象
    - 0　无
    - -　弱
    - +　有
      - ±　比有弱
    - ++　有力
      - ±±　比有力弱
    - +++　很有力
    - ++++　非常有力
    - ↑　顶
    - |　弦
    - #　变脉
    - X　细
    - TTT　跳调停
    - DDX　大大小
- 举例

		左手	右手
寸	浮	++	↑
	中	+	↑
	沉	+	X↑
关	浮	0	-
	中	-	++
	沉	+	-
尺	浮	0	0
	中	+	+
	沉	+	+

- 实例

少娟		21日		2月5		29日		1月21日		13日		1月5日	
		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮	+	+	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	++
	中	++	++	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	++	++
	沉	++	++	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	++	++
关	浮	0	-	0	-	0	0	+	↑	-	↑	-	-
	中	-	↑	-	X↑	-	+	+	↑	++	↑	+	+
	沉	++	↑	++	X↑	++	++	+	+	+	↑	++	++
尺	浮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	↑	0	0
	中	0	↑	0+#	0+#	0	+	0	0	+	↑	0	-
	沉	++	↑	0+#	0+#	++	++	-	-	-	↑	-	+#

第二天


望
（多化妆浓，仅参考）
① 头发
颜色
稀疏
② 脸色
五色
应五脏
青 肝
赤 心火
黄 脾胃
白 肺
黑 肾
③ 眼袋
大小 脾湿
颜色
黑 脾寒
紫黑 更寒
④ 气色
⑤ 状态
⑥ 仪态
⑦ 舌诊
影响较多，偏差较大
本门不用，开方不参
闻
声音
对应三种体质：
平和， 平和体质
高亢， 上热下寒体质
低沉 肾虚体质
气喘，咳嗽
语言逻辑性 言语是否错乱
口气 胃热
一问寒热
内伤
发冷 加衣服可止
发热 一会儿热，一会儿止
外感
发热 不止
发冷 盖多少被子没有用
虚热 当滋阴
脾阴
肾阴
肺阴
实热
阳明经发热
可以泻火
风寒转风热 六经传递
阳经
太阳 右寸
阳明 右关
少阳 左关
阴经
太阴 右关
少阴 尺脉
厥阴 左关
二问汗
实热 表虚 自汗
表虚 自汗
阴虚 阴虚（肾阴虚） 盗汗
汗血同源
如何处理汗

四诊
问
十问歌
三问头身
头痛
额头是阳明经 白芷
面颊是少阳经 川芎
癫顶是厥阴经 川芎
后脑是太阳经 藁本
头晕
身冷
四问便
小便
清长是寒证， 赤短是热证
白天尿频，是寒症 晚上尿频，是肾虚
大便
便秘 5天以上
是肾虚便秘
九成以上是寒秘
便溏 脾寒
次数
时间 五更泻
又名鸡鸣泄，肾泄。
由肾阳不足，命门火衰，脾肾阴寒内盛所致
五问饮食 右关问题
食欲
食量 胃热消谷，易饥饿感
凉热
胃酸
胃胀
胃痛
六问胸 胸闷
左胸
胸部
七问聋
听力下降
短暂性的炎症
脏腑功能减弱
急慢性耳聋
耳鸣
八问渴
口渴欲饮 热? 结合小便颜色、烦不烦
渴不喜水 寒? 结合小便颜色、烦不烦
九问旧病
治疗经过；
家族病（遗传、共同习惯引起）
十问因
身
心
灵
业

本门

1.累、嗜睡、手脚冰凉？　　占到两个，变脉肾虚

2.口干吗？想不想喝水
- 干，不想喝水　　右关能量低，有寒
- 干，想喝水　　右关能量高，有热

3.大小便怎么样
- 便溏，右关寒
- 尿频，白，右关寒

4.烦不烦（性子急吗）
- 烦
  - 左关能量大
  - 热？
- 郁
  - 左关能量小
  - 寒？

5.睡眠　　左关，左寸
- 难以入睡　　阳不入阴，从阴引阳
- 中途醒来　　根据时辰和脏腑的对应来判断脏腑问题

问 诊 内 容

姓名		性别	年龄		日期	
1、	寒热	怕冷	怕风	手凉	脚冷	身冷
2、	汗	自汗	盗汗	潮汗	手汗	头汗
3、	饮食	喜温热	喜冷食	食欲差	食量小	口干不渴
4、	脾胃	胃酸	胃胀	胃痛	口苦	口干喜水
5、	大便	干燥	稀溏	痔疮	便血	几天1次
6、	小便	多	淋沥	白	黄	痛
7、	睡眠	入睡难	睡中醒	夜梦多	夜尿次数	入睡时间
		起床感觉	清爽	头昏	睡不醒	起床时间
8、	精力	易累	喜睡	腰酸	腰痛	胸闷气短
9、	情志	爱发火	常郁闷	心烦躁	想事多	担心恐惧
10	月经	时间	延期	提前	来无定日	淋沥多日
		经量	太多	太少	色黑	淤块
希望着重调理的症状		①	②	③	④	⑤

切

本门特点：
脉法简单

少娟		21日 左	21日 右	2月5 左	2月5 右	29日 左	29日 右	1月21日 左	1月21日 右	13日 左	13日 右	1月5日 左	1月5日 右
寸	浮	+	+	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	++
	中	++	++	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	++	++
	沉	++	++	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	++	++
关	浮	0	-	0	-	0	0	+	↑	-	↑	-	-
	中	-	↑	-	X↑	-	+	+	↑	++	↑	+	+
	沉	++	↑	++	X↑	++	++	+	+	+	↑	++	++
尺	浮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	↑	0	0
	中	0	↑	0+#	0+#	0	+	0	0	+	↑	0	-
	沉	++	↑	0+#	0+#	++	++	-	-	-	↑	-	+#

以脉拉症
（秀）

- 左寸
  - 弱 心脉虚 — 累 — 头痛头晕
  - 大 心火大 — 头痛头晕、睡眠问题、心悸、左胸闷
- 左关
  - 弱 — 爱郁闷、慢性胃炎、肝功能异常、血脂高、胆固醇高
  - 大 脾气急
- 右寸
  - 弱 — 易感冒、无气力
  - 大 — 肩颈酸痛、胸闷
- 右关
  - 弱 — 脾胃差、口干不渴、慢性咽炎、胃闷、舒张压高、怕寒凉
  - 大 口干渴
- 尺脉
  - 弱 — 腰酸痛、体虚寒
  - 大 大烦渴

触　　手温度

1号冬暖夏凉，
2号手热脚冰或手脚都热或交替，
3号手脚冰凉，肾虚久了少腹凉

指尖冷，
手心热

注意是否有肝的问题，

可试着问问
是否有往来寒热、胸胁痞闷等症状。

手冰

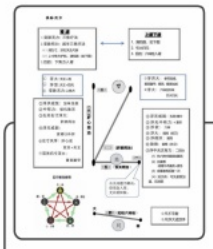
脾肾虚寒；

若手湿冷冰，

脾肾虚寒等级较高，

有时可能有特异功能　　幻听、幻视、幻觉

依脉用方图:
脉方对应，
脉方固定



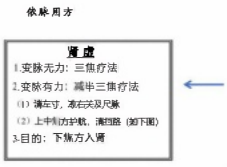
开方三部曲:

（1）判体质:
①肾虚体质
②上热下寒
③平和体质

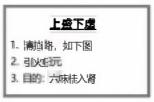
（2）定疗法:
①三焦疗法
②五脏疗法
③一体疗法

（3）开方药:
见清挡路图

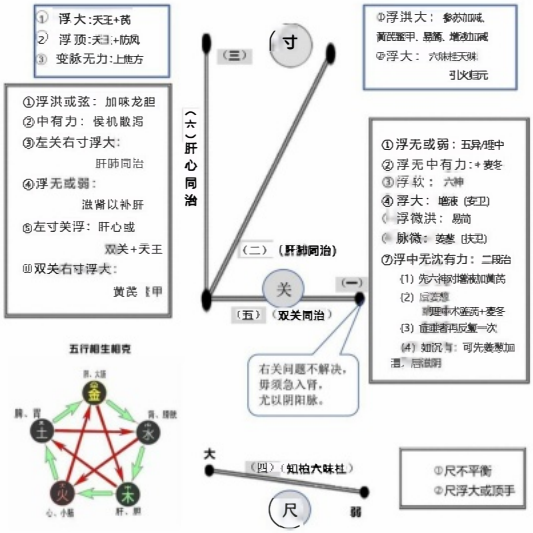
① 肾虚体质



② 上盛下虚体质



③ 平和体质
（清挡路图）



清挡路

调理
理念和步骤
（目的：五行相因）

保护上焦　　心脏受伤到一定程度　　许多药不能受
左寸不处理　　肾药不能下行

调理中焦
右关　　像一口锅
锅漏则营养不能被人体吸收
左关　　脾胃（土）养好了之后
也需要安住相克脏（木，左关）

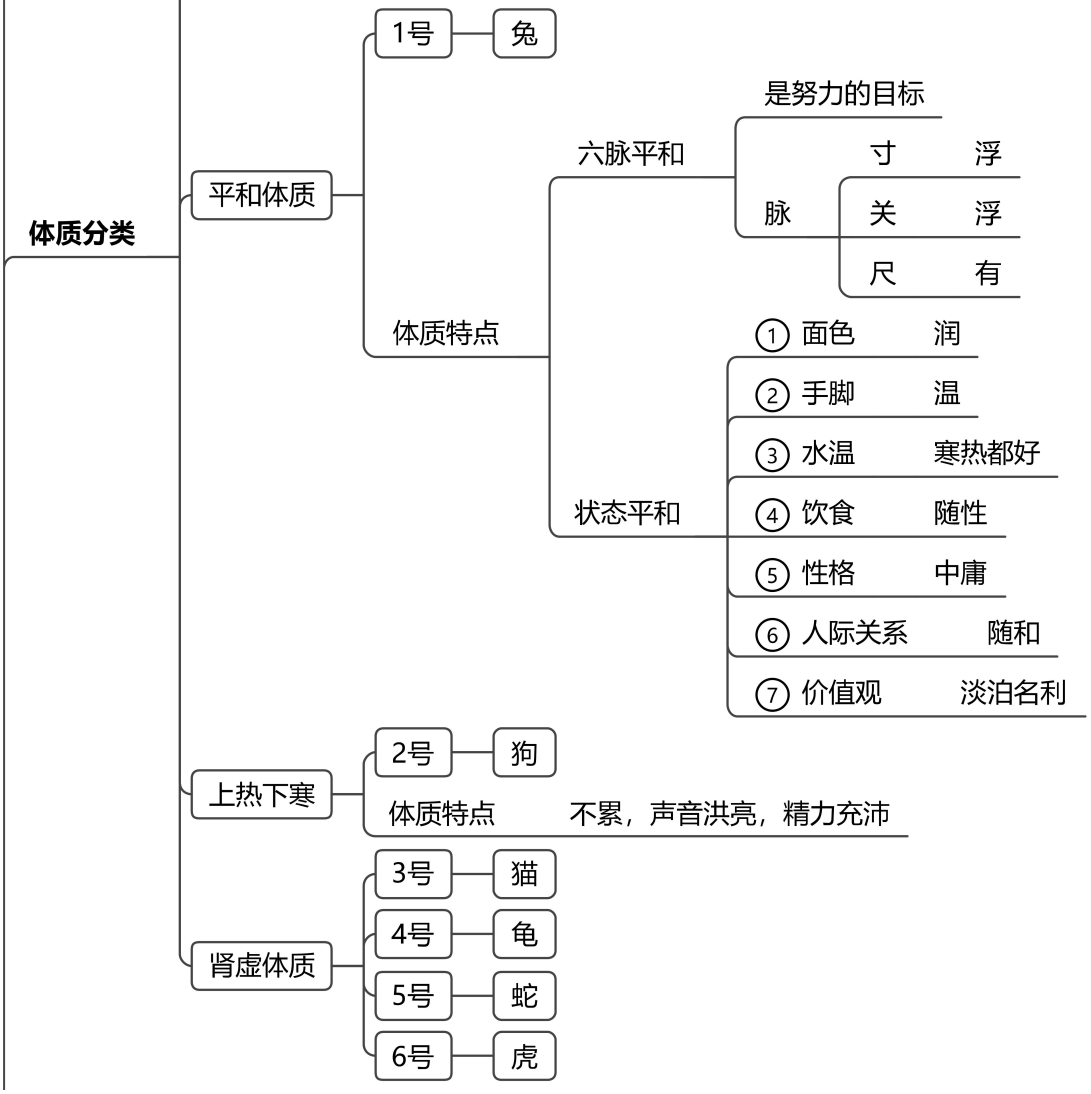
清除障碍　　穿插五脏疗法
清挡路

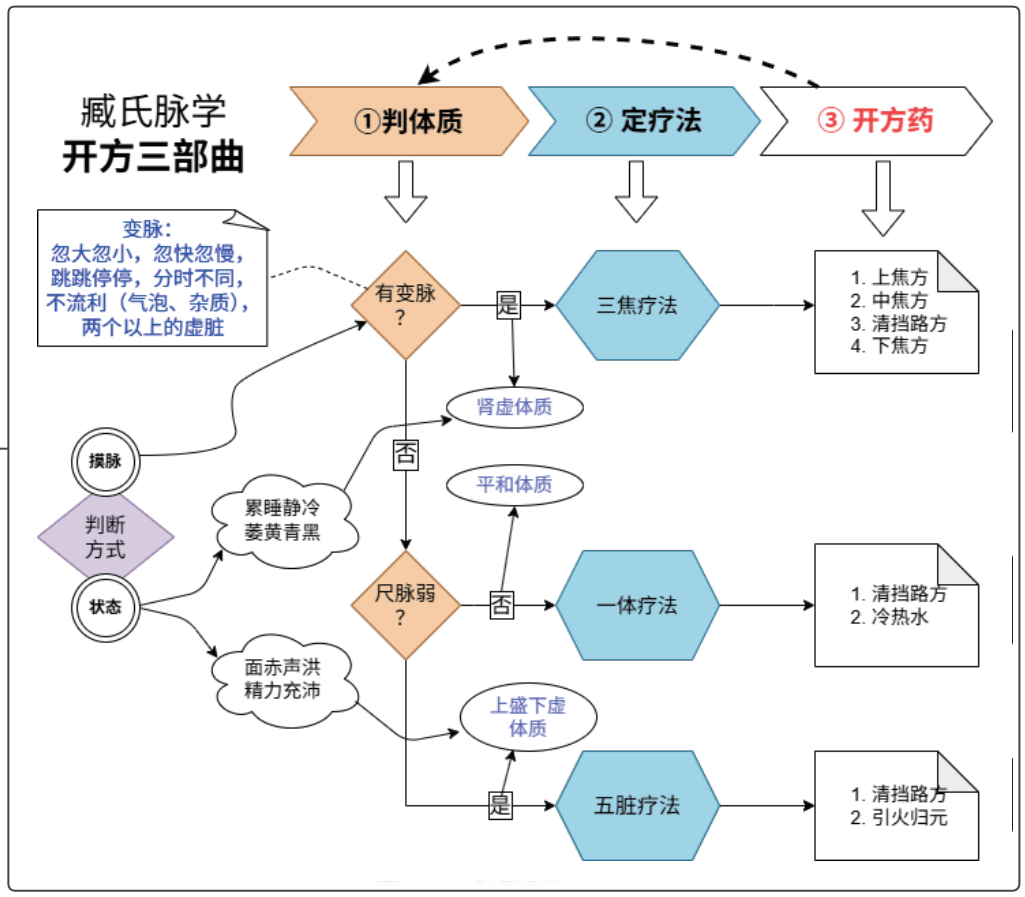
直入下焦　　补肾是目的

多采用并行

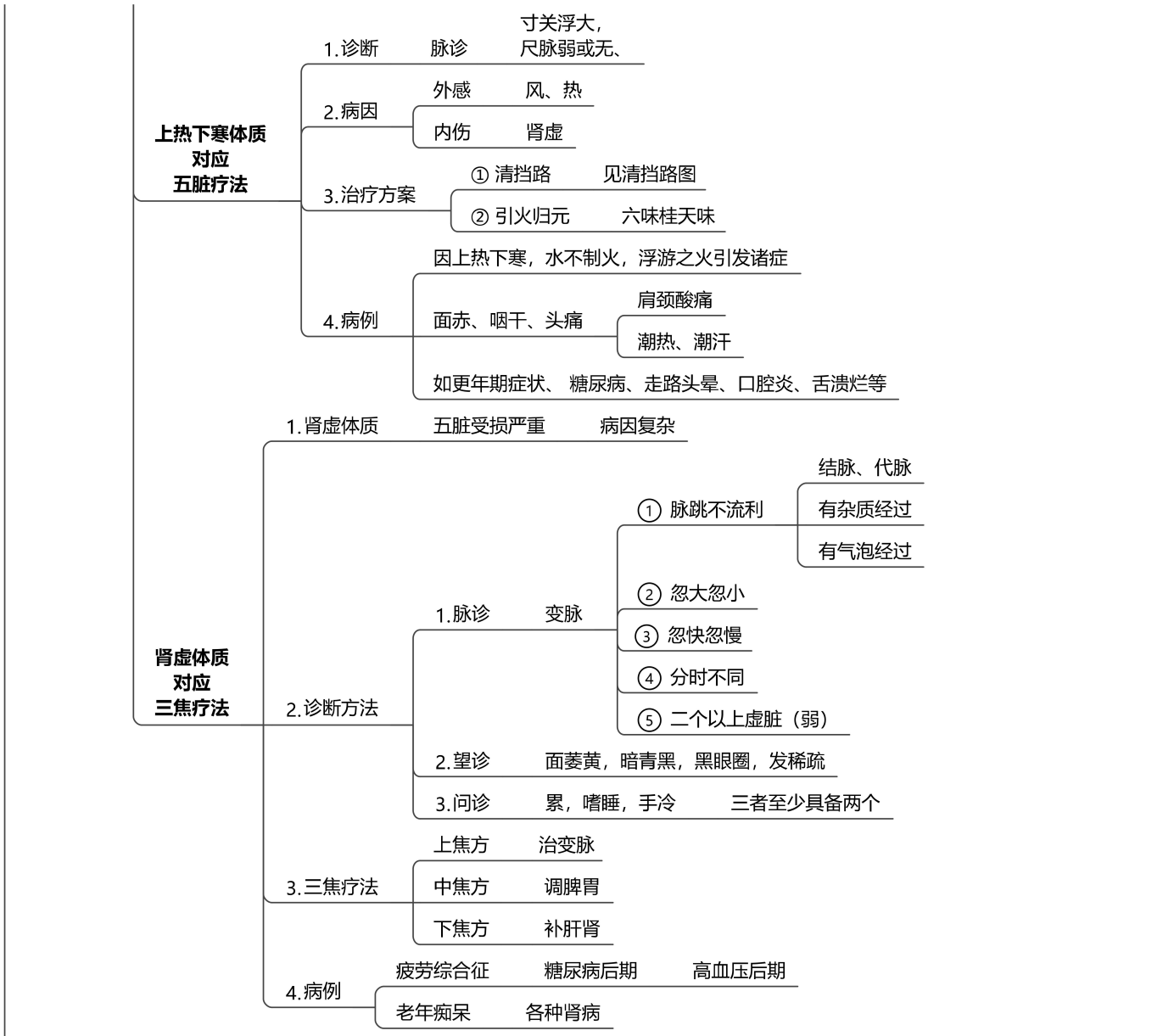
附表一 體質分類（依脈拉個性）

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
癌	性能力	常見不適	價值觀	個性	治療	切	問	聞	望
無	適中	偶爾感冒，但很快緩解	禮尚往來	溫和，沒有敵人	一體療法，圓表掃擋路各方 兔	六脈平和	需水中庸	聲平和	光潤
二期前	性欲強	陰虛發熱，手熱腳冷	好施，貼到冷屁股會受傷	夢裡的女人，坐不住想很多	引火歸元 狗	寸關浮大，尺脈弱	喝多尿多	高亢	紅赤
三期後	冷淡，尚願配合	累，手腳冰冷	面嚴肅說話直不懂施	文靜，坐得住，考試高手，喜帶口罩	三焦療法 貓	變脈	不渴	低沉	暗黑瘓黃，泛青
同上	冷淡，不願配合	同上，嗜睡	同上	同上	三焦療法，重加中溫 龜	變脈偏微	同上	同上	同上，臭臉目無神
同上	冷淡，有時會出現攻擊	全身不適，煩鬱交錯，累又睡不著或睡醒	同上	個性兩極，情緒常發洩在親密人身上	減半三焦療法，清左寸涼右關及尺 蛇	變脈有力	時狗時貓	視況大小聲	同上，目直視
同上	兩極化，有時會出現無法控制的衝動，時強烈、時冷淡	全身不適，煩多鬱少、不睡	狂施、狂買、狂省，交錯	暴躁、煩、情緒發洩不限親疏	黃耆鱉甲、知柏六味桂對服，俟脈衰，三焦再轉五臟 虎	六脈浮洪大裡壓變脈	大煩渴	大小聲	狗貓龜蛇夾雜





- 三种体质对应三种疗法
  - 平和体质对应一体疗法
    - 诊断和治疗
      - 病因简单
        - 从整体上来说，只有外感寒热造成的问题
        - 内伤寒热　　内不伤，则外不感，
      - 「冷热 水」疗法　　冷热水调脾胃
        - 依脉断寒热
          - 寒则温之，热则凉之，　　驱外感，疗内伤
          - 右关脉为依据
            - 大　冷水　　冰可乐、汽水、冰水、椰子水
            - 弱　热水　　葱姜水
            - 中有力 沉有力　　寒热夹杂　　热水凉水交替　　先用哪种？需辨
              - 阴阳水（冷热水各半）
        - 依体感冷热
          - 冷热水法
          - 加减衣服
          - 运动出汗
      - 常见病例
        - 头痛，咽喉痛
        - 临时打嗝
        - 突然睡不着
        - 腹泻



脉方对应

臧氏脉学处方		对应脉象及加减
1	一号上焦方	变脉，六弱脉
2	二号上焦方	同上，素食者
3	三号上焦方	变脉； 左寸弱且右脉有
4	五味异功散	右关弱则拉高白术； 右关浮大则拉高茯苓
5	参苓白术散	右关弱； 治疗慢性腹泻
6	六神散	右关浮软； 治疗烧退又烧
7	增液汤	右关浮大
8	加味增液汤	右关浮大； 加当归郁李仁缓解便秘
9	易简地黄饮子	右三部脉浮洪大
10	加味理中	右关弱且左关有
11	理中术姜芪	右关微； 治疗伤寒感冒
12	木香顺气	右关尺浮大顶手
13	养心汤	左寸弱迟
14	天王芪	左寸浮大数
15	肝心同治	左寸关浮大
16	肝肺同治	左关右寸浮大
17	黄芪鳖甲	双关右寸浮洪大
18	龙胆泻肝	左关洪或弦
19	参苏饮	右寸浮洪大
20	六味地黄丸	寸关浮大尺脉弱
21	明目六味地黄	寸关浮大尺脉弱 且左关大
22	知柏六味地黄	左右尺脉不平衡； 尺脉亢
23	明目知柏地黄	左右尺脉不平衡； 尺脉亢；外加左关大
24	七宝美髯丹	变脉
25	大补阴丸	尺脉洪大
26	还少丹	食疗补肾方（一付五天）
27	人参养荣汤	左右脉不平衡； 治疗脱发、产后虚、大病初愈
28	补中益气汤	双关浮大； 加散药用于虚人感冒

下午

2日班课程结束语

实操 摸脉 开方 分享

关于学习

学习的目的

学以致用

不能使用的知识，是无用的知识

记忆曲线，不做练习，容易忘记

学习的动力

有兴趣

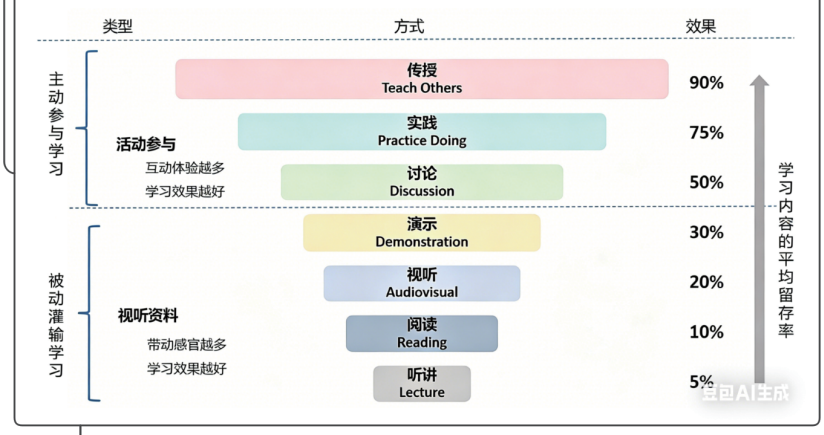
有作用

有条件

同学裹挟前进

明师适当帮助

学习方式不同
鲜果差别很大



1.被动学习 听课 阅读 看录播

2.主动学习

① 讨论

学习群

同行者

② 实践

自身 家人 同事 朋友

一定要想办法落地

1、从感冒入手

2、从脾胃入手

3、从三焦疗法入手

内化的过程是——刻意练习

③ 复述/教授

跟自己复述

整理

总结

消化

跟他人复述

简化

传授

第三天

上午 **常见病治疗理念、方法和医案**

下午 **医案解析**

开方练习

依脉用方图

肾虚

1.变脉无力：三焦疗法

2.变脉有力：减半三焦疗法

（1）清左寸，凉右关及尺脉

（2）上中焦方护航，清挡路（如下图）

3.目的：下焦方入肾

上盛下虚

1. 清挡路，如下图
2. 引火归元
3. 目的：六味桂入肾

① 浮大：天王+芪
② 浮顶：天王+防风
③ 变脉无力：上焦方

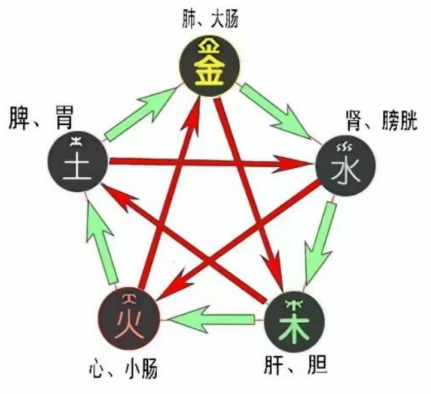
①浮洪大： 参苏加减、黄芪鳖甲、易简、增液加减
②浮大： 六味桂天味 引火归元

①浮洪或弦： 加味龙胆
②中有力： 侯机散泻
③左关右寸浮大：肝肺同治
④浮无或弱：滋肾以补肝
⑤左寸关浮：肝心或双关+天王
⑥双关右寸浮大：黄芪鳖甲

①浮无或弱：五异/理中
②浮无中有力：+麦冬
③浮软： 六神
④浮大： 增液 (安卫)
⑤浮微洪： 易简
⑥脉微： 姜葱 (扶卫)
⑦浮中无沈有力： 二段治
(1) 先六神对增液加黄芪
(2) 后姜葱 或理中术姜芪+麦冬
(3) 症重者再反复一次
(4) 如沉有：可先姜葱加温，后滋阴

右关问题不解决，毋须急入肾，尤以阴阳脉。

五行相生相克



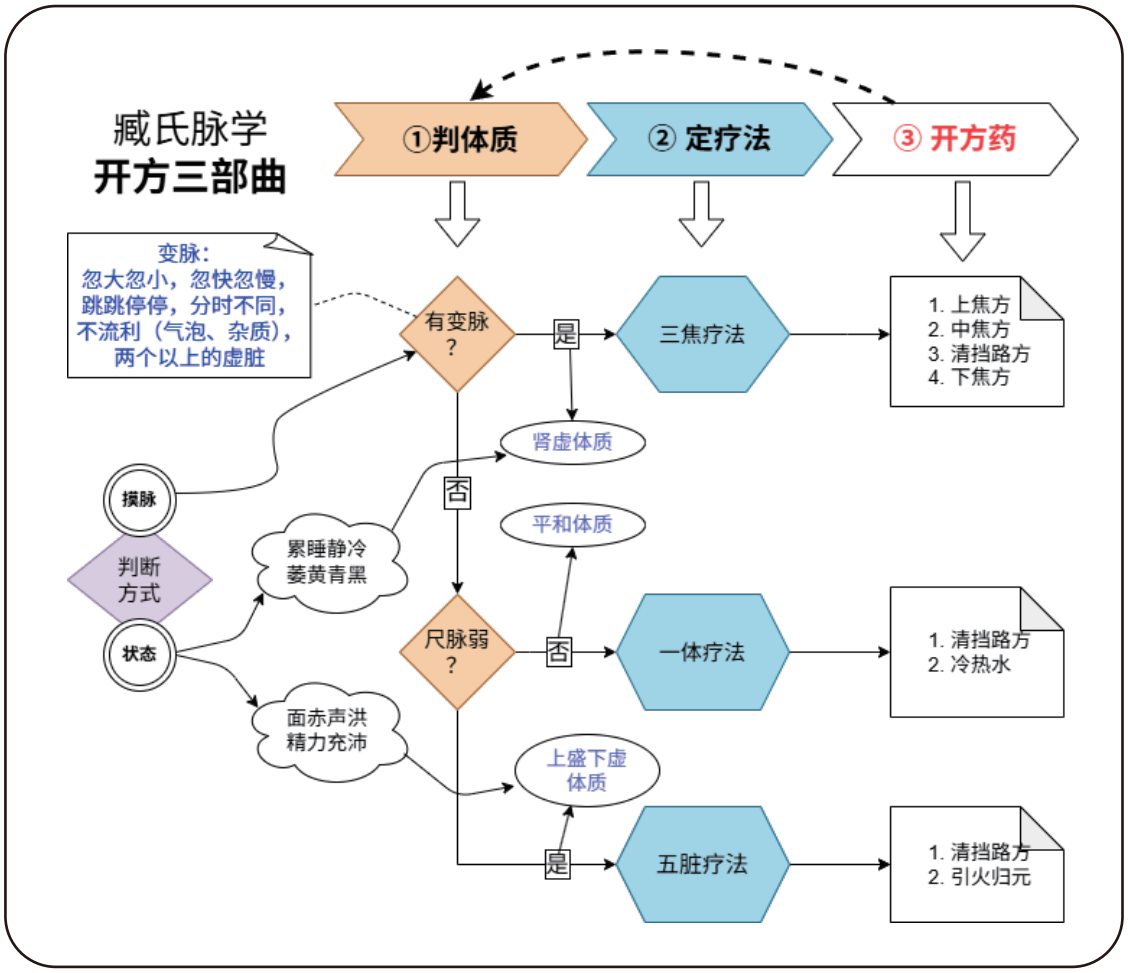
①尺不平衡
②尺浮大或顶手

依脉拉症

左		右
（一）浮顶：1.头痛、晕 2.睡眠障碍 3.心悸 （二）弱：1.晕 2.疲劳 3.胸闷（左半部）	寸	（一）浮大：1.肩颈部不适。 2.应视双关、尺脉做整体研判，如左关浮大-烦、胸闷。右关弱-慢性咽炎、口干、涎唾等。 （二）弱：胸闷、呼吸不顺畅等。
（一）浮大：1.冲右寸：（1）烦（2）胸闷；（3）肩颈不适；（4）鼻窦炎 2.冲左寸：头重痛，多见眉梢处。 （二）浮中无或弱、沈有力： 1.冲双寸：(1)烦、郁交错（2）右寸，喉痒 2.双寸弱：风冲腹腔，易引起腹部不适。如急性尿道炎，阴痒等。 （三）弱： 1.郁 2.循环失序，百病丛生，多为母脏拖累，常见： （1）肝功能异常 （2）慢性胃炎 （3）血脂及胆固醇高 （4）诸恶性肿瘤源头 （5）移于子致心脏病变，曾见主动脉剥离、二三尖瓣脉脱垂、心室肥大等重症。 （6）休息及滋肾以补肝两途，若依西医检验报告散泻，虚脏被压抑，转为浮大脉的，轻者，精神分裂，重则洗肾。	关	（一）浮大:1.有力：胃部不适，如左关弱，尺变脉，或六脉浮大，此有可能是假脉，参考望、问诊。 2.无力：诸上焦病源头，如慢性口舌疮、粘膜白斑、荨麻疹、胃出血等。 （二）浮中无、沈有力： 胃易闷痛； 此脉不解决，肾药无法下行； 冲左寸：头晕及心脏诸多不适， 如睡醒及头晕； 冲右寸：胸、肩颈、头等处不适。 （三）弱：免疫系统，如过敏性鼻炎、焦虑、口干、胃闷、舒张压高等诸多问题； 此脉不解决，肾药无法下行。
尺		
（一）尺不平衡：万恶源头，个性优柔，若有力，不受补。 （二）弱：腰腿酸软，双关无力均为其拖累。 （三）犹树之根，五行不相因源头，虚到什么程度，就会出现某种不适，除已知的肾科诸病外，风湿免疫科、恶性肿瘤、精神分裂等，和它息息相关。类固醇抑制，仅能暂时控制，并不具备治疗性、补其不足及虚损，不是那么容易，下图表1-6，若不处理，肾药无法下行。所谓调理体质，就是补充脾、肾两脏不足，使五行相因。		

附表一、 体质分类（依脉拉个性）

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
癌	**性能力**	**常见不适**	**价值观**	**个性**	**治疗**	**切**	**问**	**闻**	**望**
无	适中	偶尔感冒 但很快缓解	礼尚往来	温和， 没有敌人	一体疗法，图表扫挡路各方 兔	六脉平和	需水，中庸	声平和	光润
二期前	性欲强	阴虚发热手热脚冷	好施，贴到冷屁股会受伤	梦里的女人，坐不住，想很多	引火归元 狗	寸关浮大尺脉弱	喝多尿多	高充	红赤
三期后	冷淡，尚愿配合	累 手脚冰冷	面严肃，说话直，不懂施	文静 坐得住 考试高手 喜带口罩	三焦疗法 猫	变脉	不渴	低沉	暗黑痿黄泛青
同上	冷淡 不愿配合	同上 嗜睡	同上	同上	三焦疗法 重加中温 龟	变脉偏微	同上	同上	同上 臭脸 目无神
同上	冷淡 有时会出现攻击	全身不适 烦郁交错、累又睡不着或睡醒	同上	个性两极 情绪常发泄在亲密人身上	减半三焦疗法，清左寸凉右关及尺 蛇	变脉有力	时狗时猫	视况大小声	同上 目直视
同上	两极化，有时会出现无法控制的冲动，时强烈、时冷淡	全身不适 烦多郁少、不睡	狂施、狂买、狂省，交错	暴躁、烦、 情绪发泄不限亲疏	黄芪鳖甲、知柏六味桂对服，侯脉衰，三焦再转五脏 虎	六脉浮洪大但压变脉	大烦渴	大小声	狗猫龟蛇 夹杂



脉象记录符号

所需脉象信息			力量							粗细	频率		脉象变化			
			弦	顶	洪大	大	有	弱	无	细	数脉	迟脉	大小变	快慢变	跳跳停	分时变
左手	寸	浮	|							X	S	C	DX	KM	TTT	FS
		中		↑												
		沉			+++											
	关	浮				++										
		中					+									
		沉						-								
	尺	浮						=								
		中							0							
		沉														
右手	寸	浮														
		中														
		沉														
	关	浮														
		中														
		沉														
	尺	浮														
		中														
		沉														

脉象记录表

记录日期：　　年　　月　　日

常用脉象		① 无、弱、有、大、顶、弦				② 忽大小、跳调停、忽快慢						③ 细、数、迟、左右脉不平衡					
序号		1、		2、		3、		4、		5、		6、		7、		8、	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	

序号		9		10		11		12		13		14		15		16	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	

脉象记录表

记录日期：　　年　　月　　日

常用脉象		① 无、弱、有、大、顶、弦				② 忽大小、跳调停、忽快慢						③ 细、数、迟、左右脉不平衡					
序号		1、		2、		3、		4、		5、		6、		7、		8、	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	

序号		9		10		11		12		13		14		15		16	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	

脉象记录表

记录日期：　　年　　月　　日

常用脉象		① 无、弱、有、大、顶、弦				② 忽大小、跳调停、忽快慢				③ 细、数、迟、左右脉不平衡							
序号		1、		2、		3、		4、		5、		6、		7、		8、	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	

序号		9		10		11		12		13		14		15		16	
姓名																	
脉象		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
寸	浮																
	中																
	沉																
关	浮																
	中																
	沉																
尺	浮																
	中																
	沉																
备注																	